

GUÍA CLÍNICA

Recursos Terapéuticos para TDAH Infantil

40 actividades clínicas listas para la sesión

Niños de 4 a 10 años

Kit completo de 40 recursos basados en la TCC para TDAH, el modelo de funciones ejecutivas de Barkley, la neurociencia del desarrollo y el entrenamiento de habilidades ejecutivas. Abarcan impulsividad, atención, regulación emocional, planificación, autoestima, aversión a la tarea, fatiga ejecutiva, sueño, articulación escolar, orientación parental y cierre terapéutico. Cada recurso es autosuficiente y adaptable según la edad y el perfil del TDAH.

Terapia cognitivo-conductual

Funciones ejecutivas (Barkley)

Automonitoreo

Habilidades sociales

Índice de recursos



Cada recurso incluye objetivo, pasos de aplicación, lectura clínica, preguntas orientadoras y adaptaciones.

- 01 El Semáforo del Impulso** — Pausa entre estímulo y respuesta
- 02 El Mapa del Día** — Rutina visual para reducir conflictos cotidianos
- 03 El Juego de los 5 Minutos** — Entrenando el mantenimiento de la atención
- 04 La Caja de Herramientas del Cerebro** — Psicoeducación sobre el TDAH
- 05 La Estación del Cuerpo** — El movimiento como regulación en el TDAH
- 06 El Plan B** — Aprendiendo a manejar la frustración y el cambio de plan
- 07 El Detective del Error** — Transformando el fracaso en aprendizaje
- 08 El Sistema de Puntos** — Economía de fichas adaptada a la sesión
- 09 El Espejo del Habla** — Entrenamiento del automonitoreo verbal y conductual
- 10 La Mochila del Tiempo** — Planificación y gestión del tiempo en el TDAH
- 11 El Cuerpo Habla** — Reconocer la desregulación emocional antes de la explosión
- 12 El Proyecto Especial** — El hiperfoco como recurso terapéutico
- 13 El Mapa Mental** — Organizando visualmente los pensamientos dispersos
- 14 El Contrato Conmigo Mismo** — Autogestión para el TDAH
- 15 El Panel de Logros** — Construyendo autoestima en niños con TDAH
- 16 La Conversación con la Escuela** — Protocolo de articulación con el contexto escolar
- 17 El Juego de la Señal** — Autorregulación en el contexto social
- 18 El Pausador** — Instalar la pausa antes de responder por escrito
- 19 El Termómetro del TDAH** — Monitoreo longitudinal del tratamiento
- 20 Cerrando el Tratamiento** — Ritual de alta para el TDAH
- 21 El Radar del Ambiente** — Identificar y reducir los estímulos distractores del espacio físico
- 22 La Fila de la Cabeza** — Organizar pensamientos que compiten para hablar de a uno
- 23 El Interruptor de la Tarea** — Transiciones entre actividades sin colapso ni resistencia

- 24 La Regla del Esfuerzo** — Distinguir la pereza real de la aversión ejecutiva a la tarea
-
- 25 El Cofre de Decisiones** — Reducir la fatiga de decidir en niños con TDAH
-
- 26 El Diario del Impulso** — Registro retroactivo de impulsos para construir automonitoreo
-
- 27 El Ensayo del No** — Aprender a rechazar sin explotar ni ceder por impulso
-
- 28 El Ancla del Sueño** — Higiene del sueño adaptada al cerebro con TDAH
-
- 29 El Juego de la Escucha** — Entrenar la atención auditiva sostenida en el diálogo
-
- 30 El Velocímetro de la Voz** — Regular el ritmo, el volumen y la intensidad del habla
-
- 31 El Puente entre Sesiones** — Estructura de registro semanal para generalizar las habilidades
-
- 32 El Laboratorio del Error Académico** — Analizar los patrones de error con mirada ejecutiva
-
- 33 La Guía de Supervivencia Familiar** — Sesión psicoeducativa con padres sobre coparentalidad en el TDAH
-
- 34 La Misión Imposible** — Entrenar el inicio de tareas aversivas con estructura de juego
-
- 35 El Robot y el Artista** — Equilibrar el pensamiento estructurado y el creativo
-
- 36 La Cadena de la Consecuencia** — Entrenar la anticipación de consecuencias antes de actuar
-
- 37 El Mapa de las Amistades** — Evaluar y trabajar el campo social del TDAH
-
- 38 El Medidor de Batería** — Identificar la fatiga ejecutiva y estrategias de recarga
-
- 39 La Venda de los Ojos** — Entrenar la atención auditiva sin apoyo visual
-
- 40 El Legado del Tratamiento** — Carta y cápsula del tiempo para momentos de recaída futura
-

TIPO	Psicoeducación somática y entrenamiento de la pausa conductual
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	TDAH con impulsividad predominante — actuar antes de pensar, interrumpir, lastimarse, arrepentirse
DURACIÓN	35 a 40 minutos — ensayo en sesión; práctica diaria
MATERIALES	Hoja con el semáforo dibujado; opcional: tarjeta plastificada para llevar en la mochila

Objetivo

Enseñar al niño con TDAH el concepto de pausa deliberada entre el impulso y la acción, el principal déficit ejecutivo en la impulsividad. Los niños con TDAH no actúan por maldad: el circuito dopaminérgico que produce la pausa reflexiva entre estímulo y respuesta es neurobiológicamente menos eficiente. La intervención no busca castigar la impulsividad, sino entrenar una conducta sustituta —la pausa— que compita con la respuesta impulsiva. El semáforo es un ancla visual que el niño puede invocar mentalmente en los momentos de impulso. Se fundamenta en los protocolos de TCC para TDAH y en las técnicas de automonitoreo de Barkley.

Cómo aplicar

1

Psicoeducación sobre el impulso (5 min)

Explique con lenguaje concreto: «Tu cabeza es muy rápida: quiere actuar antes de pensar. No es tu culpa, es la forma en que funciona tu cerebro. Pero podemos entrenar un botón de pausa. El semáforo te va a ayudar a acordarte de ese botón». Normalice siempre el TDAH antes de proponer cualquier técnica: un niño que se siente defectuoso no se compromete con el tratamiento.

2

Los tres momentos del semáforo (10 min)

Presente: Rojo = PARO. Cuando sienta llegar el impulso, el primer movimiento es detenerse, no hacer nada durante 3 segundos. Amarillo = PIENSO. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué quiero que pase? Verde = ELIJO. Ahora elige la respuesta. Practique en sesión con situaciones hipotéticas concretas de la rutina del niño.

3

Ensayo con situaciones reales (15 min)

Proponga un role playing con situaciones que el niño trajo o que son típicas: un compañero que lo provoca, una maestra que le hace una crítica, querer agarrar el juguete del hermano en el momento equivocado. Para cada situación: «¿Qué dice el semáforo?». Repita el ensayo hasta que el proceso se vuelva fluido. El objetivo no es que el niño siempre tome la decisión «correcta» en el rojo, sino que haga la pausa.

4

La tarjeta de bolsillo (5 min)

Cree una tarjeta pequeña con el semáforo a color para que el niño la lleve en la mochila. acuerde una señal secreta con los padres y docentes: cuando perciban que llega el impulso, pueden hacer el gesto del semáforo con discreción para ayudar al niño a recordarlo.

Lectura clínica

Observe cómo reacciona el niño al ensayo del semáforo cuando la situación tiene carga emocional. En el TDAH, la pausa es mucho más difícil cuando hay activación emocional: la desregulación emocional, que Barkley describe como el cuarto déficit ejecutivo central del TDAH, interfiere directamente en la capacidad de usar el semáforo. Cuando el niño logra usarlo en situaciones neutras pero no en situaciones emocionales, el trabajo de regulación emocional debe preceder al de la impulsividad conductual.

Preguntas orientadoras

- Cuando llega el impulso, ¿qué sentís en el cuerpo antes de actuar?
- ¿En qué situación es más difícil usar el semáforo?
- ¿Qué pasa después cuando actuás sin pensar? ¿Cómo te quedás?
- ¿Alguna vez lograste usar el semáforo? ¿Qué fue distinto?
- ¿Qué señal podés acordar con tus papás para acordarte del semáforo?

Adaptaciones

Para niños muy impulsivos que no logran ni los 3 segundos iniciales: empiece con 1 segundo solamente. La meta no es una reflexión profunda, sino cualquier pausa, por mínima que sea. Constrúyala de forma gradual.

Para TDAH con déficit de atención predominante sin impulsividad: el semáforo es menos relevante. Priorice recursos de organización y foco.

TIPO	Construcción de soporte ambiental con rutina visual personalizada
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	TDAH con dificultad en las transiciones, resistencia a la rutina, conflictos diarios por tareas básicas
DURACIÓN	40 a 50 minutos — construcción en sesión; implementación en casa con orientación a la familia
MATERIALES	Papel A3, marcadores de colores; opcional: tarjetas plastificadas con velcro

Objetivo

Crear un soporte ambiental externo que compense la dificultad del TDAH para mantener secuencias de acción en la memoria de trabajo. Los niños con TDAH no «se olvidan» de hacer las cosas por desinterés: su sistema de memoria de trabajo —el que mantiene activas las instrucciones mientras realizan una tarea— es estructuralmente menos eficiente. Una rutina visual externaliza esa memoria de trabajo fuera del cerebro: las instrucciones quedan visibles, accesibles y en el orden correcto. El resultado práctico es una reducción drástica de los conflictos cotidianos, porque el niño ya no depende del adulto que repite lo que tiene que hacer: consulta el mapa. Esto también reduce la sensación de ser controlado todo el tiempo, lo que mejora la relación familiar.

Cómo aplicar

1

Mapeo de la rutina problemática (10 min)

Identifique con la familia qué rutina genera más conflicto, por lo general la mañana, la hora de la tarea, el baño o el momento de dormir. En sesión con el niño, mapee las etapas de esa rutina desde su punto de vista: «¿Qué necesitas hacer desde que te despiertas hasta salir para la escuela? Cuéntame en orden». Registre exactamente lo que dice el niño, no lo que los padres creen que debería hacer.

2

Construcción del mapa visual (20 min)

Con el niño, transforme la lista en un mapa visual. Cada etapa es una ilustración simple o un símbolo, no un texto largo. El niño dibuja cada etapa él mismo: esto aumenta mucho la adhesión, porque el mapa «es suyo». Agregue colores por categoría: higiene en azul, alimentación en amarillo, escuela en verde. El mapa debe tener como máximo 8 etapas; más que eso sobrecarga la atención.

3

Prueba en sesión (5 min)

Simule la rutina en sesión: «Vamos a hacer de cuenta que recién te despertaste. ¿Qué dice el mapa que es el primer paso?». Esto identifica etapas que necesitan ajuste antes de llevar el mapa a casa.

4

Orientación a la familia (10 min aparte)

Instruya a los padres: el mapa reemplaza las órdenes verbales repetidas. En lugar de «andá a lavarte los dientes», el adulto señala el mapa en silencio. Esto reduce el tono de reclamo y enseña autodirección. Los primeros 7 días exigen más supervisión; luego el niño tiende a ganar autonomía.

Lectura clínica

Observe qué incluye y qué omite el niño en su versión de la rutina. Las etapas que omite suelen ser las más conflictivas, no porque no sepa que existen, sino porque le resultan aversivas. Cuando el mapa ya está implementado y la familia informa que el niño «todavía no hace» determinada etapa, investigue si esa etapa se olvida genuinamente (déficit de memoria de trabajo) o se evita de forma sistemática (un problema conductual distinto). La intervención para cada caso es diferente.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué parte de la rutina es la que más detestás? ¿Por qué?
- ¿Qué suele distraerte en medio de la rutina?
- Si pudieras armar la rutina perfecta a tu manera, ¿cómo sería?
- Cuando lográs hacer todo en orden, ¿cómo te sentís?
- ¿Qué podrías poner en el mapa para que esas etapas sean menos aburridas?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: use solo símbolos y fotos reales del niño haciendo cada etapa (tomadas por los padres). La imagen del propio niño aumenta el reconocimiento y la identificación con la rutina.

Para niños que sabotean el mapa después de unos días: investigue si la rutina está demasiado rígida o si cambió algo en el ambiente. Revise el mapa cada 2 semanas para mantener su relevancia.

TIPO	Entrenamiento de atención sostenida con estructura de juego y refuerzo inmediato
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	TDAH con déficit de atención predominante — niño que no logra sostener la atención en tareas por períodos mínimos
DURACIÓN	30 a 40 minutos por sesión
MATERIALES	Temporizador visible (reloj de arena o timer de cocina), actividad preferida del niño, sistema de puntos simple

Objetivo

Entrenar la atención sostenida de forma gradual y positiva, partiendo del principio de que la atención es una habilidad que se desarrolla con práctica estructurada, no exigiendo un esfuerzo mayor a la capacidad actual. El error más común con niños con TDAH es exigir períodos de atención incompatibles con su ventana neurobiológica actual, lo que genera fracaso, vergüenza y aversión a la tarea. Esta técnica va en la dirección opuesta: comenzar con períodos de atención que el niño ya logra con alta tasa de éxito (aunque sean 2 minutos) y ampliarlos gradualmente. El temporizador visible es fundamental porque externaliza la noción de tiempo: los niños con TDAH tienen una dificultad intensa con la percepción temporal interna.

Cómo aplicar

1

Calibración de la ventana de atención actual (5 min)

Antes de empezar el entrenamiento, evalúe la ventana de atención real del niño en la sesión, no lo que informan padres o docentes, sino lo que usted observa. Proponga una actividad moderadamente interesante y observe cuánto tiempo sostiene la atención antes de la primera dispersión. Ese es el punto de partida del entrenamiento: no el ideal, sino el real.

2

Estructura del juego (20 min)

Defina con el niño una actividad que le guste pero que requiera atención sostenida: rompecabezas, juego de memoria, dibujo con detalles. Configure el temporizador 1 o 2 minutos por debajo de la ventana observada. Regla del juego: mientras corre el timer, el niño se enfoca en la actividad sin interrupción. Cuando suena, ganó un punto. Si se dispersa antes, el punto no cuenta, pero no hay castigo, solo ausencia de refuerzo. Repita durante 4 o 5 rondas por sesión.

3

Progresión gradual (a lo largo de las semanas)

Aumente el tiempo 1 o 2 minutos por semana, solo cuando la tasa de éxito de la semana anterior haya superado el 80%. La progresión lenta es lo que garantiza la consolidación neurobiológica. Registre gráficamente el tiempo de atención semana a semana: el gráfico es uno de los refuerzos más motivadores para niños con TDAH, que responden fuertemente al feedback visual e inmediato.

Lectura clínica

Observe la calidad de la atención, no solo su duración. Un niño que se queda el tiempo pero mira para todos lados, toca todo y produce de forma aleatoria está presente físicamente pero no atentivamente. Un niño que se dispersa pero vuelve rápido cuando se lo recuerda demuestra mejor control ejecutivo que aquel que nunca se dispersa pero tampoco se recupera. La capacidad de volver al foco tras la dispersión es una habilidad ejecutiva separada e igualmente importante de entrenar.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué pasa en tu cabeza cuando estás tratando de concentrarte y se te va?
- ¿Hay alguna actividad en la que puedas concentrarte mucho tiempo? ¿Qué tiene de distinto?
- Cuando suena el timer, ¿cómo te sentís si lograste quedarte concentrado?
- ¿Qué es lo que más te distrae dentro del aula?
- Si pudieras cambiar una cosa del ambiente para concentrarte mejor, ¿cuál sería?

Adaptaciones

Para niños con ventana de atención muy corta (menos de 2 minutos): empiece con 1 minuto y no lo sienta como poco. Para algunos niños, 1 minuto de atención sostenida con éxito es un avance real. El refuerzo consistente del logro pequeño consolida más que la exigencia de períodos largos.

Para TDAH con hiperactividad intensa: incluya intervalos de movimiento obligatorio entre las rondas — saltar, correr por el pasillo, sacudir los brazos—. En estos niños el movimiento no perjudica la atención; con frecuencia la mejora.

TIPO	Psicoeducación sobre el TDAH adaptada al lenguaje infantil
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Todo niño con TDAH — aplicar en las primeras sesiones como base de todas las intervenciones siguientes
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande, marcadores; opcional: imágenes simplificadas del cerebro

Objetivo

Ofrecer al niño con TDAH una explicación comprensible, no estigmatizante y empoderadora sobre su propio funcionamiento cerebral, lo que Barkley llama «desmitificación diagnóstica». Los niños con TDAH suelen llegar al tratamiento con una narrativa de identidad negativa construida por años de fracaso y crítica: «soy vago», «soy tonto», «no me importa». La psicoeducación no elimina las dificultades, pero cambia el encuadre: en lugar de un defecto de carácter, las dificultades son déficits ejecutivos específicos en un cerebro que también tiene fortalezas únicas. Este cambio de narrativa es la base motivacional de todo el trabajo terapéutico posterior.

Cómo aplicar

1

La analogía del auto de carrera (10 min)

Explique: «¿Viste los autos de carrera? Algunos cerebros con TDAH son como autos de carrera: motor potentísimo, muy veloz, mucha energía. El problema es que el volante y los frenos a veces no acompañan al motor. No es que el auto sea malo: necesita una forma especial de ser manejado». Deje que el niño reaccione. Pregunte: «¿Esto se parece a vos?».

2

La caja de herramientas (15 min)

Explique que el cerebro de todos tiene una caja de herramientas ejecutivas: planificación, memoria de trabajo, control del impulso, atención, regulación emocional. «En el TDAH, algunas herramientas son más chicas o más difíciles de usar. No faltan, están ahí. Pero necesitan más entrenamiento y a veces ayuda externa». Dibujen juntos la caja de herramientas y el niño escribe el nombre de cada una. Para cada herramienta, pregunte: «¿Esta es fácil o difícil para vos?».

3

Los superpoderes (10 min)

Pregunte: «¿Y cuáles son las herramientas que usás muy bien? ¿Qué hacés mejor que la mayoría?». Los niños con TDAH suelen tener creatividad, hiperfoco en temas de interés, pensamiento lateral y energía excepcional. Nombre esto explícitamente y escríbalo en la caja. El objetivo es una imagen completa — déficits y fortalezas —, no una lista solo de problemas.

4

Qué cambia ahora (5 min)

Explique que el trabajo terapéutico se va a enfocar en entrenar las herramientas más difíciles y en crear soportes externos que las reemplacen cuando haga falta. «No necesitás arreglar el motor. Vamos a aprender a manejar mejor».

Lectura clínica

Observe cómo reacciona el niño a la información sobre el TDAH. Un niño que ya internalizó mucho la narrativa del defecto puede tener dificultad para aceptar la explicación neurobiológica: «pero yo podría hacerlo si quisiera». Esa resistencia debe ser acogida y trabajada: la creencia de que el TDAH es vagancia o falta de voluntad es la que más alimenta la vergüenza y el bajo autoconcepto. Observe también a los niños que usan el diagnóstico como excusa generalizante: «no hago nada por el TDAH». Ese uso necesita calibración: el TDAH explica algunas dificultades, no todas las decisiones.

Preguntas orientadoras

- ¿Alguien ya te explicó qué es el TDAH antes? ¿Qué te dijeron?
- ¿Qué creés que piensan las personas de vos por el TDAH?
- ¿Hay algo que hacés muy bien que las personas a veces ignoran?
- Si el TDAH fuera una persona, ¿cómo sería?
- ¿Qué te gustaría que las personas supieran sobre cómo es tener TDAH?

Adaptaciones

Para niños que todavía no conocen el diagnóstico: la psicoeducación se hace de acuerdo con los padres y adaptada a lo que la familia decidió comunicar. No revele el diagnóstico sin un acuerdo previo con la familia.

Para niños que ya conocen el diagnóstico y sienten mucha vergüenza: empiece por los superpoderes antes de hablar de los déficits. La secuencia importa cuando la autoestima está muy comprometida.

TIPO	Intervención somática de regulación por movimiento — base neurocientífica
EDAD	4 a 10 años
DEMANDA	TDAH con hiperactividad intensa, dificultad para permanecer sentado en sesión, dispersión extrema por activación motora
DURACIÓN	Integrado a lo largo de todas las sesiones — no es una actividad aislada
MATERIALES	Bolita, pelota antiestrés, piso de goma, espacio para el movimiento

Objetivo

Integrar el movimiento físico a las sesiones como regulador neurobiológico, no como una perturbación a contener. La investigación en neurociencia del TDAH muestra de forma consistente que el movimiento físico —en especial el que involucra coordinación bilateral— aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal, mejorando temporalmente las funciones ejecutivas. Un niño con TDAH que se mueve durante la sesión no está faltando el respeto: se está autorregulando. Intentar inmovilizarlo para que «preste atención» a menudo empeora la atención. El recurso propone incorporar el movimiento de forma estructurada e intencional, transformando una dificultad en aliada.

Cómo aplicar

1

Estructura general de las sesiones con TDAH hiperactivo

Divida cada sesión en bloques alternados de actividad sentada y actividad en movimiento. Propuesta para una sesión de 50 min: 10 min de movimiento inicial de descarga (saltar la soga, jugar a la pelota, caminar rápido por el pasillo); 15 min de actividad sentada con un objeto de movimiento permitido (pelota antiestrés, banda elástica en la pata de la silla para presionar); 10 min de movimiento medio (una actividad que involucra el cuerpo con componente cognitivo: búsqueda del tesoro con pistas, juego de mímica terapéutico); 15 min de actividad sentada final.

2

Objetos de regulación sensorial para las actividades sentadas

Algunos objetos permiten movimiento discreto sin salir de la silla y son reguladores eficaces: banda elástica atada a las patas de la silla para empujar con los pies; pelota antiestrés o spinner para las manos; almohadón de textura en la silla; chicles, ya que la masticación activa circuitos de regulación oral que compiten con la dispersión.

3

Enseñanza del autoconocimiento regulatorio (5 min por sesión)

Pregunte con regularidad: «¿Tu cuerpo necesita moverse ahora o está bien?». Enseñe al niño a reconocer las señales internas de hiperactivación antes de que estalle en una conducta disruptiva. Cuando logre nombrar «necesito moverme», proponga: «¿Hacemos 20 saltos ahora y después seguimos?». Esto instala el automonitoreo, la habilidad ejecutiva más valiosa para el TDAH.

Lectura clínica

Observe la calidad del trabajo cognitivo antes y después del movimiento. En la mayoría de los niños con TDAH hiperactivo, el período de 10 a 20 minutos posterior a la actividad física intensa es el de mayor foco y productividad. Use esa ventana para las tareas de mayor demanda cognitiva. Un niño que queda más agitado después del movimiento —en lugar de más regulado— puede estar en un estado de hiperexcitación, no de hipoestimulación, y puede necesitar técnicas de reducción de la activación en lugar de movimiento.

Preguntas orientadoras

- ¿Sabés cuándo tu cuerpo necesita moverse? ¿Cómo te das cuenta?
- ¿Qué pasa dentro tuyo cuando estás mucho tiempo quieto?
- Después de moverte bastante, ¿te concentrás mejor o peor?
- ¿Hay algo que puedas hacer con discreción en el aula para regularte?
- ¿Tu maestra sabe que pensás mejor cuando podés moverte un poco?

Adaptaciones

Para niños en contexto escolar: oriente a la familia para que comunique a la escuela sobre los objetos de regulación sensorial. Los chicles, las bandas en la silla y las pelotas antiestrés no son un privilegio ni un desorden: son una adaptación razonable para el TDAH que mejora el desempeño académico.

Para TDAH con déficit de atención sin hiperactividad: el movimiento es menos crítico. Estos niños suelen regularse mejor con estimulación visual y auditiva suave: música instrumental de fondo, iluminación adecuada, reducción de estímulos visuales en el ambiente.

TIPO	Entrenamiento de flexibilidad cognitiva y tolerancia a la frustración
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con baja tolerancia a la frustración, explosiones cuando los planes cambian, rigidez ante los obstáculos
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Tarjetas de situación, hoja con espacio para los planes A, B y C

Objetivo

Desarrollar la flexibilidad cognitiva —la capacidad de cambiar de estrategia cuando la primera no funciona—, uno de los déficits ejecutivos más relevantes clínicamente en el TDAH. Los niños con TDAH suelen quedar «atrapados» en la solución original cuando el plan cambia, reaccionando con una intensidad desproporcionada a frustraciones que a otros les parecen menores. Esa rigidez no es terquedad: es una dificultad neurobiológica para cambiar el foco atencional. El entrenamiento del Plan B instala una secuencia automática: cuando el plan A falla, no catastrofizar, sino activar el plan B; cuando el B falla, activar el C. La idea de que «todo problema tiene más de una solución posible» es la base cognitiva de este recurso.

Cómo aplicar

1

La filosofía del plan B (5 min)

Presente: «¿Viste los pilotos de avión? Antes de volar planean la ruta, pero siempre tienen un plan B por si algo cambia. No porque va a salir mal, sino porque los pilotos inteligentes se preparan. Las personas con TDAH son muy buenas para crear el plan A, pero a veces quedan tan pegadas a él que cuando cambia, se traban. Hoy vamos a entrenar el plan B».

2

Situaciones de práctica (20 min)

Use situaciones reales de la rutina del niño donde suele explotar o trabarse cuando el plan cambia. Para cada una, construyan juntos tres planes: A (lo que el niño realmente quiere), B (lo posible si A no se da) y C (el mínimo aceptable si tampoco se da B). Generar B y C antes de que aparezca la frustración es el entrenamiento. Ejemplo: «Quiero jugar al videojuego (A), pero se cortó la luz. Plan B: jugar a un juego de mesa. Plan C: leer historietas».

3

Ensayo emocional (10 min)

Simule en role playing el momento de transición del plan A al B, con algo de activación emocional. Pregunte: «¿Qué sentís cuando el plan A se cae? ¿Qué hace tu cuerpo?». Trabaje específicamente ese momento de transición, que es donde ocurre la explosión. Instale la frase gatillo: «Está bien, paso al plan B».

Lectura clínica

La velocidad y la intensidad de la reacción al cambio de plan son un indicador del nivel de regulación emocional del niño en ese momento. Los niños con TDAH que presentan explosiones muy intensas ante frustraciones mínimas pueden tener un TDAH con desregulación emocional severa, que Barkley describe como «déficit de regulación emocional» —distinto del trastorno del estado de ánimo, pero igualmente incapacitante—. En estos casos, el trabajo de regulación emocional precede al entrenamiento de flexibilidad cognitiva.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuándo fue la última vez que el plan cambió y te frustraste mucho? ¿Qué pasó?
- ¿Qué sentís en el cuerpo cuando las cosas no salen como planeaste?
- ¿Alguna vez el plan B terminó siendo mejor que el plan A?
- ¿Qué te ayuda a pasar del plan A al plan B sin explotar?
- ¿Conocés a alguien que sea bueno para improvisar? ¿Qué aprendés de esa persona?

Adaptaciones

Para niños con rigidez muy intensa (posible TDAH + perfeccionismo o rasgos de TEA): no fuerce la generación de planes alternativos en la primera sesión. Construya de a poco la tolerancia a lo «distinto de lo planeado» con situaciones de muy baja carga emocional.

Para TDAH con impulsividad que genera planes A muy inmediatistas: trabaje primero la calidad del plan A —una reflexión breve antes de actuar— antes de agregar las alternativas.

TIPO	Reestructuración cognitiva sobre el error y el fracaso con foco en TDAH
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con autoestima muy baja, reacciones intensas a los errores, abandono rápido tras el fracaso, vergüenza crónica
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja con la estructura de investigación del error, lapicera

Objetivo

Modificar la relación del niño con TDAH con el error, que suele ser de vergüenza, catastrofización y abandono. Los niños con TDAH acumulan estadísticamente más experiencias de fracaso que sus pares a causa de los déficits ejecutivos, y desarrollan lo que algunos investigadores llaman «sensibilidad a la rechazo disfórica»: una hipersensibilidad al fracaso y a la crítica que puede ser tan incapacitante como los propios síntomas del TDAH. El Detective del Error usa la metáfora científica: los errores son datos, no juicios morales. Los detectives no se avergüenzan de los errores que investigan; los usan como pistas para encontrar la solución. Este encuadre transforma la relación con el fracaso, de algo a esconder a algo a analizar.

Cómo aplicar

1

El error como dato (5 min)

Presente la filosofía: «Un detective no se avergüenza de las pistas. Las pistas son información. Los errores son lo mismo: dicen algo sobre lo que pasó y sobre lo que podemos hacer distinto. Hoy vamos a investigar un error tuyo como detectives». Elija un error reciente que el niño trajo o que sea relevante.

2

La investigación (20 min)

Arme la ficha de investigación del error elegido: ¿Qué pasó exactamente? (describa sin juzgar, solo hechos). ¿Qué estaba pasando antes? (qué sentía, qué pensaba, el ambiente). ¿Qué herramienta ejecutiva estaba fallando? (¿atención?, ¿impulsividad?, ¿memoria?, ¿planificación?). ¿Qué podrías haber hecho distinto? (no «deberías», sino «podrías»). ¿Qué te está enseñando este error para la próxima? La pregunta sobre qué herramienta ejecutiva fallaba es central: conecta el error con el TDAH sin quitarle responsabilidad al niño: «La herramienta falló. ¿Qué podés hacer para apoyarla la próxima vez?».

3

El plan de ajuste (5 min)

Al final, el niño define una cosa concreta que va a intentar distinto en la próxima situación similar. Pequeña, específica, posible. No una promesa de perfección.

Lectura clínica

Observe la reacción emocional del niño al nombrar el error en la sesión. Un niño que minimiza en exceso («no fue nada, ya me olvidé») puede estar usando el olvido como defensa contra la vergüenza. Un niño que catastrofiza («soy un fracaso total») está en fusión cognitiva con el error. Ambos necesitan abordajes distintos: el que minimiza necesita espacio para sentir el impacto real; el que catastrofiza necesita distancia y perspectiva. La técnica del detective sirve mejor al segundo; para el primero, el trabajo es de acceso emocional antes del análisis.

Preguntas orientadoras

- Cuando te equivocás, ¿qué te decís a vos mismo?
- ¿Creés que otros también se equivocaron en esa situación? ¿Cómo reaccionaron?
- ¿Qué te diría un buen amigo sobre este error?
- ¿Qué aprendiste de este error que te va a ayudar la próxima vez?
- ¿Qué herramienta ejecutiva necesitás apoyar más para no equivocarte de la misma forma?

Adaptaciones

Para errores con consecuencias graves (pegarle a un compañero, lastimar a alguien): la investigación se hace, pero el procesamiento emocional y el trabajo de responsabilización y reparación deben ir antes del análisis técnico. No use la técnica del detective para desviar el impacto de la conducta en los demás.

Para niños que se resisten a hablar de sus errores: empiece con un error ficticio de un personaje. Aplique la ficha de investigación al personaje: la distancia permite acceder al proceso sin la vergüenza del error propio.

TIPO	Técnica conductual de refuerzo positivo estructurado — economía de fichas
EDAD	5 a 9 años
DEMANDA	TDAH con baja motivación para tareas no preferidas, oposicionismo asociado, dificultad para completar tareas sin refuerzo inmediato
DURACIÓN	15 min de presentación en sesión; sistema implementado en casa y en la escuela
MATERIALES	Tarjeta de puntos, fichas o stickers, lista de recompensas negociada con la familia

Objetivo

Implementar un sistema de refuerzo positivo estructurado que compense el déficit dopaminérgico del TDAH, que vuelve las tareas no inmediatamente recompensadoras mucho más aversivas que para los niños sin TDAH. El cerebro con TDAH no se motiva por recompensas futuras de la misma forma que los cerebros neurotípicos: la moneda de cambio debe ser inmediata, frecuente y muy tangible. La economía de fichas ofrece exactamente eso: cada conducta objetivo se refuerza de inmediato con una ficha o punto, y los puntos acumulados se cambian por recompensas negociadas de antemano. El psicólogo tiene un papel central en la estructuración y el ajuste del sistema, pero la implementación la hace la familia.

Cómo aplicar

1

Definición de las conductas objetivo (10 min en sesión con los padres)

Seleccione con la familia 3 a 5 conductas específicas y observables para reforzar. Regla: conductas positivas a instalar, no conductas negativas a eliminar. En lugar de «no interrumpir», use «levantar la mano antes de hablar». En lugar de «no desordenar el cuarto», use «guardar la mochila antes de dormir». La positividad de la definición es fundamental: el sistema refuerza lo que se quiere más, no castiga lo que se quiere menos.

2

Estructura de puntos y recompensas (10 min)

Cada conducta objetivo tiene un valor en puntos (1 a 3 según la dificultad). El niño puede cambiar puntos por recompensas de tres niveles: pequeña (10 puntos — elegir qué se come en la cena), mediana (30 puntos — 30 minutos extra de videojuego), grande (60 puntos — un paseo elegido por él). Las recompensas se negocian con la familia y el niño juntos en sesión: esto aumenta el compromiso del niño con el sistema.

3

Explicación al niño en sesión (15 min)

Presente el sistema de forma lúdica: «Vas a ganar puntos por cada cosa que hagas. Los puntos se transforman en premios. Vos decidís qué querés ganar». Evite todo tono de castigo. El sistema es de recompensa, nunca de resta de puntos ya conquistados.

Lectura clínica

El sistema de puntos funciona como un diagnóstico en funcionamiento: cuando el niño no responde ni siquiera con recompensas muy deseables, eso indica que la dificultad conductual tiene componentes más allá del déficit motivacional dopaminérgico. Puede haber una oposición más profunda, un ambiente muy inconsistente en la aplicación, o conductas objetivo demasiado difíciles para el nivel actual de regulación del niño. Revise el sistema antes de concluir que la técnica no funciona.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué recompensa te gustaría ganar más que ninguna?
- ¿Cuál de las conductas creés que vas a poder hacer más fácil?
- ¿Qué es lo que más te complica cuando intentás hacer esas cosas?
- ¿Preferís ganar muchos puntos chicos o pocos puntos grandes?
- ¿Cómo te vas a sentir cuando consigas el premio grande?

Adaptaciones

Para niños más grandes (8 a 10 años) que encuentran el sistema demasiado infantil: cambie las fichas y stickers por una app de puntaje en el celular o por un gráfico de barras que el niño completa él mismo. El formato adulto mantiene la función.

Para familias con dificultad de consistencia: simplifique al extremo. Una conducta objetivo, un punto, una recompensa pequeña y diaria. La consistencia de una conducta simple es más eficaz que la inconsistencia de un sistema complejo.

TIPO	Técnica de automonitoreo con uso de grabación y feedback
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con impulsividad verbal — interrumpir, hablar sin pensar, volumen alto inapropiado, responder antes de que termine la pregunta
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Celular con grabador de voz, auriculares

Objetivo

Desarrollar el automonitoreo de la conducta verbal, una habilidad en la que los niños con TDAH tienen un déficit significativo por la dificultad de mantener un «observador interno» funcionando a la vez que la acción. En el TDAH, el habla suele preceder al pensamiento: el niño habla y solo después procesa lo que dijo y el impacto en los demás. El uso de grabación de voz y de feedback auditivo diferido crea de manera artificial el observador interno que está ausente: el niño se escucha como lo escuchan los demás, lo que a menudo genera insights que la observación interna en tiempo real no logra producir.

Cómo aplicar

1

Presentación y acuerdo (5 min)

Explique: «Hoy vamos a hacer algo distinto. Voy a grabar un pedacito de nuestra charla y después lo vas a escuchar. La idea no es juzgar, es que te veas desde afuera, como un actor que mira su propio ensayo para mejorar». Obtenga el acuerdo explícito del niño.

2

Conversación grabada (10 min)

Conduzca una conversación sobre un tema de interés del niño durante 10 minutos con el grabador encendido. Cree situaciones sutiles que activen la conducta objetivo: interrúmpalo a la mitad y observe si lo nota; haga preguntas largas y observe si responde antes de que termine; baje su volumen y observe si modula el suyo.

3

Escucha y análisis (15 min)

Escuchen juntos la grabación. Antes de empezar, defina qué van a observar: «Hoy vamos a prestar atención a cuántas veces empezaste a hablar mientras yo todavía hablaba». Escuche al niño; no le señale, deje que él lo identifique. Cuando lo identifique, pregunte: «¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Sabías que lo estabas haciendo?». Esa pregunta sobre la conciencia en tiempo real es el núcleo del automonitoreo.

4

Plan de práctica (5 min)

Defina con el niño una conducta verbal específica para monitorear durante la semana. Acuerde una señal que pueda usar consigo mismo cuando se dé cuenta —un toque en el labio, una respiración— que funcione como pausa verbal.

Lectura clínica

La reacción del niño al escuchar su propia voz es clínicamente reveladora. Un niño que se ríe nervioso o minimiza al escuchar conductas impulsivas puede estar usando el humor como defensa para no procesar el impacto. Un niño que se angustia mucho al escucharse puede tener alta autoconciencia pero baja tolerancia a la imperfección. Ambos necesitan abordajes distintos: el que minimiza necesita una devolución directa sobre el impacto real en los demás; el que se angustia necesita validación y perspectiva antes del análisis.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué escuchaste en la grabación que te sorprendió?
- ¿Cómo creés que me sentí cuando me interrumpiste?
- ¿Sabías en tiempo real que lo estabas haciendo o recién te diste cuenta al escucharlo?
- ¿Qué te hace querer hablar antes de que la persona termine?
- ¿Qué señal secreta podés darte a vos mismo cuando sientas el impulso de hablar?

Adaptaciones

Para niños que se sienten muy incómodos con la grabación: empiece grabando solo al psicólogo hablando. Escuchen juntos esa grabación. Esto normaliza el proceso de escucharse antes de aplicarlo al niño.

Para conductas no verbales como la agitación motora: use video en lugar de audio. El niño se ve moviéndose, a menudo con genuina sorpresa, porque no tiene conciencia corporal de cuánto se mueve.

TIPO	Entrenamiento de la habilidad de planificación y de la percepción temporal
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con dificultad de gestión del tiempo — llegar tarde, no calcular cuánto tardan las tareas, dejar todo para último momento
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Temporizador visible, hoja de planificación, lapicera

Objetivo

Desarrollar la percepción temporal —que Barkley describe como uno de los déficits ejecutivos más fundamentales del TDAH— mediante un entrenamiento estructurado de estimación y planificación. Los niños con TDAH viven en un «ahora» y un «no-ahora»: el futuro es abstracto y poco motivador, el pasado se olvida rápido, y la estimación de cuánto tarda algo es crónicamente incorrecta. Esto produce demoras constantes, tareas incompletas y conflictos familiares por el tiempo. La «mochila del tiempo» usa dos mecanismos: (1) estimar el tiempo antes de ejecutar tareas y verificarlo después, construyendo una calibración interna gradual; (2) externalizar el tiempo con un temporizador visual, volviendo concreto lo abstracto.

Cómo aplicar

1

El juego de la estimación (15 min)

En sesión, proponga tres actividades simples de duración conocida por usted pero no por el niño: escribir 10 palabras, armar un rompecabezas de 20 piezas, caminar de la sala a la recepción y volver. Antes de cada una, pregunte: «¿Cuánto tiempo creés que va a llevar esto?». Anote la estimación. Haga la actividad con el temporizador. Compare. La diferencia entre estimación y realidad es el dato clínicamente rico. Los niños con TDAH suelen subestimar de 3 a 5 veces.

2

Construyendo la mochila del tiempo (15 min)

Explique: «Tu cerebro todavía está aprendiendo a calcular el tiempo. Vamos a crear una mochila del tiempo: un registro de cuánto suelen tardar tus actividades, para que lo uses de referencia». Armen juntos una lista: cuánto tarda el baño, la tarea de matemática, ordenar la mochila, almorzar. Ese banco de datos externo reemplaza la percepción temporal interna que está comprometida.

3

La planificación en reversa (10 min)

Enseñe a planificar de atrás hacia adelante: «Tenés que salir a las 7:30. El baño lleva 15 min, el desayuno 10 min, vestirse 10 min. Entonces tenés que levantarte a las 6:55». Este razonamiento inverso es contraintuitivo para los niños con TDAH, pero es lo que más combate las demoras crónicas.

Lectura clínica

Observe el patrón de error en la estimación del tiempo. Un niño que subestima de forma consistente (cree que todo es más rápido) tiene dificultad de percepción de la duración, típica del TDAH. Un niño que sobreestima (cree que todo va a tardar mucho) puede tener ansiedad de desempeño superpuesta al TDAH, donde la preocupación por la tarea dilata la percepción de la duración. Las intervenciones son diferentes.

Preguntas orientadoras

- ¿Solés sorprenderte de lo rápido que pasó el tiempo?
- Cuando tenés una fecha de entrega, ¿cómo decidís cuándo empezar?
- ¿Alguna vez te quedaste sin tiempo para terminar algo porque no calculaste bien?
- ¿Qué tarea es la que más subestimás en el tiempo que lleva?
- ¿El temporizador te ayuda a notar cuánto tiempo está pasando?

Adaptaciones

Para niños muy pequeños (4 a 6 años): use el timer de cocina como único recurso: «tenés hasta que suene el timer para terminar esto». No entrene la estimación todavía; entrene solo la conciencia de que el tiempo pasa.

Para niños con procrastinación intensa: combine la planificación en reversa con el principio de «solo 5 minutos»: «vas a trabajar solo 5 minutos en la tarea; si querés parar después, podés». La mayoría continúa más allá de los 5 minutos una vez iniciada la tarea: el inicio es el peor obstáculo para el TDAH.

TIPO	Entrenamiento de conciencia emocional somática para TDAH con desregulación emocional
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con explosiones emocionales intensas y rápidas, dificultad para prever las propias reacciones, remordimiento después de la explosión
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Silueta corporal, marcadores de colores

Objetivo

Desarrollar la capacidad de reconocer las señales físicas de desregulación emocional antes de que ocurra la explosión, creando una ventana de intervención donde no había ninguna. Los niños con TDAH y desregulación emocional suelen describir sus explosiones como «de la nada», lo que no es del todo cierto neurológicamente, pero refleja la velocidad con la que la activación pasa de cero al pico sin una pausa perceptible. El entrenamiento de conciencia somática intenta desacelerar y ampliar esa ventana: el niño aprende a identificar señales físicas tempranas de la activación emocional (tensión en el hombro, calor en la cara, opresión en el pecho) antes de que se vuelvan incontrolables, creando un punto de intervención precoz.

Cómo aplicar

1

Mapeo retroactivo (10 min)

Elija una explosión reciente que el niño recuerde. Reconstruya la escena en retrospectiva: «¿Qué estaba pasando antes? ¿Qué sentías antes de explotar? Si le pusieras una nota del 0 al 10 al enojo de ese momento, ¿cuándo estabas en 3?, ¿en 5?, ¿en 8? ¿Qué hacía tu cuerpo en cada número?». El objetivo es reconstruir la escala que el niño no percibió en tiempo real.

2

Mapeo corporal del enojo (15 min)

Entregue la silueta. Pida al niño que pinte dónde siente el enojo en el cuerpo, en cada nivel de la escala. Use colores distintos por nivel: azul para el inicio (3), amarillo para el medio (6), rojo para el pico (10). La mayoría descubre que en el 3 y en el 6 había señales físicas que nunca había notado conscientemente: la mandíbula que se cierra, los puños que se aprietan, la voz que sube, el corazón que se acelera.

3

La señal de alerta personal (5 min)

Identifique con el niño la primera señal física que aparece, el indicador de que está saliendo del 0 hacia el 3. Esa señal se vuelve el gatillo de intervención: «Cuando sientas [señal específica], es hora de usar la herramienta de regulación antes de llegar al 10».

4

La herramienta de regulación en el 3 (5 min)

Acuerde una acción específica para usar al notar la señal de alerta: la respiración del dragón, salir del ambiente por 2 minutos, apretar una pelotita. La herramienta debe decidirse en un momento de calma: en el pico del enojo no hay capacidad de elegir.

Lectura clínica

Observe la capacidad del niño de reconstruir la escala en retrospectiva. Los niños con desregulación emocional muy intensa a menudo no logran identificar ningún momento por debajo del 7: la activación es tan rápida que el sistema de reconocimiento no alcanza a registrar los primeros niveles. En estos casos, el trabajo de atención plena al cuerpo debe ser más extensivo y puede requerir técnicas de biofeedback o mindfulness corporal más sistemático antes de instalar la intervención precoz.

Preguntas orientadoras

- Cuando ya estás en 10, ¿es posible hacer algo para calmarte?
- ¿Qué hace tu cuerpo cuando empieza a enojarse, antes de explotar?
- ¿Hay alguien que se da cuenta de que vas a explotar antes que vos?
- Después de explotar, ¿cómo te sentís? ¿Qué pensás?
- ¿Qué necesitarías para poder salir del ambiente antes de llegar al pico?

Adaptaciones

Para niños que no logran identificar ninguna señal física: empiece con sesiones de atención plena al cuerpo en estado de calma, un escaneo corporal diario de 3 minutos. El niño necesita primero aprender a sentir el cuerpo neutro antes de reconocer las señales de activación.

Para TDAH con desregulación emocional que implica conducta agresiva: combine el trabajo clínico con orientación parental sobre cómo responder durante la explosión sin escalar. El trabajo del niño y la conducta del adulto durante la crisis son igualmente importantes.

TIPO	Intervención basada en las fortalezas — aprovechamiento del hiperfoco
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con autoestima muy comprometida por el foco excesivo en los déficits; uso terapéutico del hiperfoco como palanca de compromiso
DURACIÓN	20 min de identificación; proyecto de varias sesiones
MATERIALES	Variable según el tema de interés del niño

Objetivo

Aprovechar el hiperfoco —una de las características más distintivas y a menudo subestimadas del TDAH— como motor de compromiso terapéutico y como andamiaje para desarrollar habilidades ejecutivas en un contexto motivador. El hiperfoco en el TDAH es la capacidad de atención sostenida e intensa en actividades de alto interés, con frecuencia muy superior a la media. Terapéuticamente, esto significa que el niño que «no logra concentrarse en nada» a menudo puede hacerlo durante horas en Minecraft, dinosaurios, fútbol o cocina. El proyecto especial usa ese tema de hiperfoco como vehículo para entrenar planificación, organización, ejecución y revisión —las mismas funciones ejecutivas deficitarias— en un contexto donde la motivación intrínseca es alta.

Cómo aplicar

1

Identificación del tema de hiperfoco (10 min)

Pregunte: «Si pudieras pasar un día entero haciendo solo una cosa que amás, ¿cuál sería?» y «¿Hay algún tema que, cuando alguien empieza a hablar de él, no podés parar de escuchar?». Identifique el tema o la actividad de hiperfoco. No juzgue la elección: videojuego, autos, recetas, animales, deporte. El tema es el vehículo, no el objetivo.

2

Propuesta del proyecto (10 min)

Proponga: «¿Y si hacemos un proyecto sobre [tema]? Un proyecto de verdad, con investigación, planificación y presentación». Negocie el formato: puede ser un libro, una presentación, un video, un mapa, un experimento. El niño elige el producto final.

3

Ejecución a lo largo de las sesiones (varias sesiones)

Cada etapa del proyecto es una oportunidad de entrenar una función ejecutiva específica: planificar las etapas (organización y anticipación), dividir en subtarefas menores (fragmentación), investigar con foco (atención selectiva), ejecutar dentro de un plazo (gestión del tiempo), revisar el producto (automonitoreo), presentar (habilidad social y comunicación). Procese cada etapa de forma explícita: «Para hacer eso que querés, ¿qué pasos necesitás dar?».

Lectura clínica

El proyecto especial funciona también como una evaluación ecológica de las funciones ejecutivas: observe cómo planifica el niño, si logra dividir en etapas sin ayuda, si sostiene el interés cuando la tarea incluye partes menos estimulantes, cómo reacciona cuando un plan no funciona. Esta evaluación en un contexto de alto interés revela el nivel real de capacidad ejecutiva sin la interferencia de la desmotivación, que con frecuencia difiere de lo que informan padres y docentes.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué querés que las personas sepan sobre este tema al final del proyecto?
- ¿Cuáles son los pasos que necesitás dar para llegar ahí?
- ¿Qué parte del proyecto es la que más esperás? ¿Y la que menos?
- ¿Cómo vas a saber que el proyecto está terminado?
- Si te quedaras trabado en alguna parte, ¿qué harías?

Adaptaciones

Para niños cuyo tema de hiperfoco es un videojuego o los medios: no intente redirigirlo hacia algo «más educativo». Use el propio tema: «¿Hacemos una guía del juego que más te gusta?». La función ejecutiva que se entrena es la misma sin importar el tema.

Para niños con TDAH sin hiperfoco aparente: el hiperfoco puede haber quedado suprimido por años de frustración y fracaso. Explore actividades anteriores preguntando qué hacía el niño antes de «abandonar todo».

TIPO	Técnica de organización cognitiva con soporte visual externo
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con pensamiento fragmentado, dificultad para organizar ideas antes de hablar o escribir, dificultad en redacciones y exposiciones orales
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Hoja grande A3, marcadores de colores

Objetivo

Ofrecer un soporte externo para la organización del pensamiento que compense la dificultad del TDAH para mantener múltiples informaciones organizadas en la memoria de trabajo de forma simultánea. Los niños con TDAH suelen tener un pensamiento muy asociativo y creativo, pero no lineal. Cuando necesitan organizar ese pensamiento para una tarea (redacción, respuesta oral, proyecto), la no linealidad se vuelve una dificultad porque las tareas académicas exigen secuencia. El mapa mental externaliza el pensamiento asociativo en un formato visual que después puede linealizarse. Es una herramienta de adaptación que respeta el estilo cognitivo del TDAH en lugar de forzarlo a pensar de forma lineal desde el inicio.

Cómo aplicar

1

La idea central (3 min)

Identifique el tema o la tarea que necesita organizarse: puede ser una tarea escolar, una historia que el niño quiere contar, un argumento que quiere presentar. Escriba el tema en el centro de la hoja, dentro de un círculo.

2

Expansión libre (10 min)

Pida al niño que vuelque libremente todo lo que le viene a la cabeza sobre el tema: palabras, frases, imágenes, conexiones. Sin censura, sin orden. Usted escribe o escribe él, a medida que llegan las ideas. Use líneas que parten del centro para conectar ideas relacionadas. Este es el momento del pensamiento asociativo libre: no interfiera con el orden.

3

Agrupamiento y secuenciación (10 min)

Con todas las ideas en el papel, pida al niño que observe: «¿Hay algo que combine con otra cosa?». Agrupe con colores. Después: «Si le fueras a contar esto a alguien, ¿por qué idea empezarías?». Esa secuenciación posterior al mapa es lo que transforma el pensamiento asociativo en comunicación lineal, y es mucho más fácil de hacer cuando las ideas ya están visibles en el papel.

4

Producción a partir del mapa (10 min)

Pida al niño que use el mapa para producir la tarea original: escribir la redacción, dar la explicación, contar la historia. Compare la calidad y la organización con producciones anteriores hechas sin el mapa.

Lectura clínica

El mapa mental es también una ventana al estilo cognitivo del niño. Mapas muy densos y sin conexiones claras indican un pensamiento muy asociativo que necesita más trabajo de categorización. Mapas muy dispersos y superficiales pueden indicar dificultad de acceso al propio contenido mental, lo que es distinto de la falta de ideas. Observe si el niño se entusiasma más en el momento de expansión libre (cuando no hay presión de organizar) o en el de secuenciación (cuando hay estructura): eso revela en qué fase del proceso interfiere más el TDAH.

Preguntas orientadoras

- Mirando el mapa, ¿qué ves que no sabías que sabías sobre este tema?
- ¿Qué parte del mapa fue más fácil: volcar ideas u organizarlas?
- ¿Qué diferencia notás cuando escribís con el mapa delante?
- ¿Hay algún lugar en la escuela donde podrías usar el mapa mental?
- ¿Qué usarías para hacer el mapa cuando no tengas papel, por ejemplo en una prueba?

Adaptaciones

Para el uso en pruebas: enseñe al niño a hacer un minimapa en su propio cuaderno antes de responder una pregunta de desarrollo. Treinta segundos de mapeo antes de escribir mejoran significativamente la organización de la respuesta.

Para niños con dificultad de escritura asociada (disgrafía o lentitud grafomotora): use solo palabras clave y símbolos en el mapa, nunca frases completas. El mapa es una herramienta de pensamiento, no de producción de texto.

TIPO	Técnica de autogestión conductual — contrato de conducta
EDAD	8 a 10 años
DEMANDA	TDAH en fase de mayor autonomía — niño que ya tiene algún repertorio de automonitoreo y está listo para gestionar conductas con menos supervisión adulta
DURACIÓN	40 a 45 minutos — construcción en sesión; revisión cada 2 semanas
MATERIALES	Hoja de contrato (puede hacerse a mano en la sesión), lapicera

Objetivo

Desarrollar la autogestión conductual, el nivel más avanzado de las intervenciones para TDAH, donde el niño pasa de ser gestionado por el ambiente a gestionarse a sí mismo. Las etapas de intervención para TDAH progresan de la gestión externa (el adulto controla el ambiente y los refuerzos) a la gestión interna (el propio niño monitorea, evalúa y refuerza su conducta). El contrato conmigo mismo es una herramienta de transición entre esas dos etapas: tiene la estructura de un contrato formal (lo que aumenta el compromiso) pero lo hace el niño y para el niño, sin depender del adulto para su ejecución. Indicado para niños que ya responden bien al sistema de puntos y demuestran alguna capacidad de automonitoreo.

Cómo aplicar

1

Identificación de la conducta objetivo (10 min)

El niño elige —no el adulto— qué conducta quiere trabajar. Esto es fundamental para el compromiso. Pregunte: «¿Hay algo que vos mismo quisieras cambiar en tu comportamiento? ¿Algo que sabés que te complica pero que no lográs controlar solo?». La elección del niño suele ser más relevante clínicamente de lo que el adulto imagina.

2

Estructura del contrato (15 min)

El contrato tiene los siguientes elementos, todos completados por el niño: qué me comprometo a hacer (conducta específica y observable); cuándo y dónde lo voy a hacer; cómo voy a saber si lo hice (criterio de éxito); qué voy a hacer para recompensarme cuando lo logre (recompensa autoadministrada); qué voy a hacer si no lo logro (plan de retomada, no castigo); fecha de revisión: cuándo voy a evaluar si funciona. El niño firma el contrato. El psicólogo puede firmar como testigo, pero el contrato es con él mismo, no con usted.

3

Revisión quincenal (10 min en sesión)

Cada dos semanas, revisen el contrato: qué funcionó, qué no funcionó, qué hay que ajustar. El contrato es un documento vivo: puede renegociarse.

Lectura clínica

La calidad de la conducta que el niño elige trabajar revela el nivel de conciencia que tiene sobre su propio TDAH. Un niño que elige conductas muy vagas («ser más organizado») todavía no tiene suficiente autoconocimiento ejecutivo para el contrato. Refínela con él: «¿Cuál sería una cosa específica de organización que harías distinto?». Un niño que elige conductas muy difíciles puede estar siendo perfeccionista o intentando cumplir expectativas de los adultos, no las propias. Pregunte: «¿Esta es una conducta que vos querés cambiar, o que alguien quiere que cambies?».

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué elegiste esa conducta y no otra?
- ¿Qué va a ser distinto en tu vida cuando lo logres?
- ¿Cuál es la parte más difícil de este contrato?
- ¿Qué vas a hacer el día que no logres cumplir el contrato?
- ¿Cómo vas a saber que está funcionando sin necesitar que alguien te lo diga?

Adaptaciones

Para niños más pequeños (5 a 7 años): no use contratos formales. Reemplácelos por un acuerdo visual simple, con imagen de la conducta y de la recompensa, sin lenguaje contractual.

Para niños que hacen el contrato pero no lo cumplen: investigue las barreras específicas. Con frecuencia la conducta elegida es más difícil de lo que el niño estimó, o el ambiente no está cooperando. Ajuste antes de concluir que la técnica no funciona.

TIPO	Intervención de construcción de autoconcepto positivo con registro visual
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	TDAH con autoestima crónicamente baja, identidad basada en fracasos, niño que no reconoce ninguna fortaleza
DURACIÓN	Proyecto de varias sesiones — iniciado temprano en el tratamiento y ampliado a lo largo del proceso
MATERIALES	Cartulina o papel kraft, marcadores, fotos opcionales, materiales de decoración

Objetivo

Construir activamente un repositorio visual de logros, fortalezas y cualidades que el niño con TDAH pueda consultar en los momentos de baja autoestima, que son frecuentes e intensos en esta población. Los niños con TDAH acumulan estadísticamente más críticas, retos y experiencias de fracaso que sus pares, y desarrollan una narrativa de identidad predominantemente negativa. El panel de logros crea un contrapeso material y permanente: no es una lista de elogios genéricos, sino un documento personalizado y creciente de evidencias reales de competencia, esfuerzo y carácter.

Cómo aplicar

1

Creación y primeras secciones (30 min)

Presente el panel como un proyecto serio: «Este panel va a registrar quién sos de verdad: no solo las dificultades, sino en qué sos bueno, qué lograste, qué valoran de vos las personas que te quieren». Estructure el panel en secciones: «Lo que ya logré» (realizaciones concretas); «En esto soy bueno» (habilidades y fortalezas); «Lo que dicen de mí» (la mirada de los demás; pida que la familia contribuya por escrito o con fotos); «Lo que aprendí que no sabía» (crecimiento y aprendizaje). El niño inicia cada sección en la sesión y la amplía a lo largo del tratamiento.

2

Uso longitudinal (10 min por sesión)

Comience cada sesión con la pregunta: «¿Hay algo para poner en el panel esta semana?». Celebre cada agregado. Con el tiempo, el panel se vuelve un documento de identidad robusto. Cuando el niño llegue a una sesión diciendo «no soy bueno en nada», pídale que mire el panel. La discrepancia entre lo que siente en ese momento y lo que el panel documenta es el punto de intervención cognitiva.

Lectura clínica

Observe qué elige poner el niño en el panel de forma espontánea versus qué pone solo cuando usted lo sugiere. Los logros que elige sin sugerencia representan el autoconcepto positivo al que ya tiene acceso; los que requieren sugerencia son los que están más bloqueados por la narrativa negativa. Estos últimos son los más importantes de trabajar: pregunte por qué el niño no los pensó de forma espontánea y qué le impide reconocerlos como logros reales.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué pondrías en el panel que todavía no está?
- Si un amigo tuyo hiciera este panel, ¿qué pondría sobre vos?
- ¿De qué logro del panel estás más orgulloso?
- Cuando mirás todo esto junto, ¿qué pensás de vos?
- ¿Qué querés que esté en el panel dentro de seis meses?

Adaptaciones

Para niños que se resisten al panel por vergüenza («parece que me estoy agrandando»): normalice que reconocer fortalezas no es arrogancia, es autoconocimiento honesto. «Lo que no podés hacer es ver solo lo malo. El panel es para ver el cuadro completo».

Para familias con un clima muy crítico: incluya una sesión específica con los padres pidiéndoles que aporten tres cualidades que reconocen en el niño. Ese ejercicio es transformador tanto para el niño como para la relación familiar.

TIPO	Protocolo de articulación interinstitucional — sesión con la familia y comunicación con la escuela
EDAD	Niños de 5 a 10 años en contexto escolar
DEMANDA	TDAH con impacto escolar significativo — quejas de conducta, bajo rendimiento, docentes sin información sobre TDAH
DURACIÓN	50 a 60 minutos con la familia + carta/informe para la escuela
MATERIALES	Modelo de informe escolar, lista de adaptaciones razonables

Objetivo

Articular el trabajo terapéutico con el contexto escolar, que es donde el TDAH más impacta la vida del niño. La escuela suele ser el campo de batalla donde el niño con TDAH más fracasa, más recibe críticas y más desarrolla la narrativa de incapacidad. Una escuela mal orientada amplifica los déficits ejecutivos; una escuela bien orientada y con adaptaciones adecuadas puede ser uno de los factores protectores más poderosos del tratamiento. El psicólogo tiene un papel fundamental de puente entre el saber clínico y el saber pedagógico: no para decirle a la docente qué hacer, sino para traducir las dificultades del niño a un lenguaje práctico y proponer adaptaciones que cualquier docente pueda implementar sin recursos extra.

Cómo aplicar

1

Mapeo del contexto escolar con la familia (15 min)

Antes de cualquier comunicación con la escuela, mapee: ¿cuáles son las quejas específicas de la escuela?, ¿en qué materias el impacto es mayor?, ¿cómo es la relación de la docente con el niño?, ¿la escuela ya tiene alguna orientación sobre TDAH?, ¿hay apertura para adaptaciones? Este mapeo define la estrategia de comunicación.

2

Preparación del informe para la escuela

El informe debe incluir (sin lenguaje clínico excesivo): cómo se manifiesta el TDAH específicamente en este niño (no el diagnóstico genérico); qué verá el docente en el aula que es manifestación del TDAH, no vagancia ni falta de respeto; adaptaciones de bajo costo que mejoran mucho el desempeño (sentarse cerca del docente, reducir estímulos visuales en el pupitre, instrucciones cortas y en partes, permitir movimiento discreto); qué no hacer (llamar la atención delante del grupo, exigir períodos largos de tarea sin pausa, castigar conductas que son síntomas); cómo comunicarse con la familia cuando ocurre algo significativo.

3

Orientación a la familia sobre cómo comunicarse con la escuela (20 min)

Oriente a los padres sobre el tono y la estrategia: «El objetivo es ser socio de la escuela, no adversario. Las docentes reciben poca formación sobre TDAH. La postura de '¿cómo podemos trabajar juntos?' abre muchas más puertas que 'mi hijo tiene derecho a...'. La colaboración produce más que la exigencia».

Lectura clínica

Observe cómo describe la familia a la escuela y a la docente. Una familia que habla de la escuela con hostilidad intensa suele estar transfiriendo a la escuela la frustración con el diagnóstico y con la situación del niño, lo que puede sabotear la articulación. Trabaje la postura de la familia antes de proponer cualquier contacto con la escuela. Una familia que minimiza el impacto escolar («la maestra está exagerando») puede estar en negación sobre la magnitud del impacto del TDAH, lo que también requiere trabajo previo a la articulación.

Preguntas orientadoras para los padres

- ¿Cómo es la relación del niño con la docente actual?
- ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que hace la escuela?
- ¿La escuela sabe del diagnóstico? ¿Cómo fue la reacción?
- ¿Ya intentaron hablar con la escuela sobre adaptaciones? ¿Cómo fue?
- ¿Qué necesitarían para sentirse seguros en esa conversación con la escuela?

Adaptaciones

Para escuelas muy resistentes al diagnóstico de TDAH: el informe no necesita mencionar el diagnóstico si la familia lo prefiere. Se puede hablar de un «perfil atencional específico» y proponer las mismas adaptaciones prácticas sin la etiqueta diagnóstica.

Para niños cuyo impacto escolar es predominantemente conductual, con quejas de agresividad: la articulación con la escuela debe incluir un plan de manejo de crisis acordado: qué hace la docente cuando el niño pierde el control, cuándo llamar a los padres, cómo registrar los incidentes.

TIPO	Entrenamiento de habilidades sociales con foco en las dificultades específicas del TDAH
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con dificultad para esperar el turno, sumarse a juegos en curso, mantener amistades, leer señales sociales
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Fichas de situación social, espacio para role playing

Objetivo

Entrenar específicamente las habilidades sociales impactadas por los déficits ejecutivos del TDAH: esperar el turno (inhibición de respuesta), leer las señales de cuándo entrar y cuándo salir de una situación (atención a las señales sociales), mantener el tema de conversación (memoria de trabajo social), controlar el volumen y la intensidad de la interacción (regulación). Los niños con TDAH suelen conocer las reglas sociales; el problema es ejecutarlas en tiempo real, a demanda, cuando el sistema ejecutivo está bajo presión. El entrenamiento debe ser repetido, gradual y en contextos progresivamente más cercanos a lo real.

Cómo aplicar

1

Mapeo de las dificultades sociales específicas (10 min)

Identifique con el niño y con la familia qué situaciones sociales son las más problemáticas. Ejemplos comunes: sumarse al juego del recreo sin ser invitado, perder en un juego y no poder manejarlo, dominar la conversación hablando solo del tema propio, quedar afuera por ser «demasiado molesto». Elija una situación específica para trabajar por sesión.

2

Análisis de la escena (5 min)

Para cada situación, identifiquen juntos: «¿Qué suele pasar? ¿Qué hacés vos? ¿Cómo reaccionan los otros chicos? ¿Qué te gustaría que pasara distinto?». Esto mapea la brecha entre la conducta actual y la conducta objetivo.

3

Ensayo en role playing (20 min)

Dramatice la situación con el niño. Incluya: modelado por usted primero (cómo sería una conducta social adaptada), ensayo del niño, feedback específico y positivo, repetición. Para «esperar el turno»: practique con juegos de mesa dentro de la sesión. Para «sumarse al juego»: role play del momento de pedir. Para «mantener la conversación»: ejercicio de «charla de a dos turnos», uno habla, otro responde, uno habla.

4

Generalización acordada (5 min)

Acuerde una situación real para que el niño la intente durante la semana con la habilidad entrenada. Sea específico: «En el recreo del jueves, intentá sumarte a un juego usando la frase que ensayamos».

Lectura clínica

Distinga el déficit de conocimiento del déficit de ejecución. Un niño que sabe qué hacer pero no lo hace tiene un déficit de ejecución: el problema es ejecutar bajo presión social real. Un niño que no sabe qué hacer tiene un déficit de conocimiento. El entrenamiento para cada uno es distinto: el déficit de conocimiento requiere enseñanza explícita de las reglas sociales; el de ejecución requiere práctica repetida con feedback hasta que la respuesta se vuelva más automática.

Preguntas orientadoras

- ¿Sabés lo que deberías hacer en esa situación, pero no lográs hacerlo en el momento?
- ¿Qué pasa por tu cabeza mientras intentás usar la habilidad social?
- ¿Cómo te das cuenta de que estás dominando demasiado la conversación?
- ¿Hay algún amigo que te parece que es bueno en esto? ¿Qué hace?
- ¿Qué te gustaría que los otros chicos supieran sobre vos para tener más paciencia?

Adaptaciones

Para niños rechazados por el grupo de pares de forma consolidada: el trabajo de habilidades sociales individual puede no ser suficiente. Considere la derivación a un grupo terapéutico de habilidades sociales, donde el entrenamiento ocurre en un contexto social real con pares.

Para TDAH con predominio de inatención que pasa desapercibido socialmente: las dificultades son diferentes —tendencia a «desaparecer» en la conversación, perder el hilo de lo que el otro dice, mirar hacia otro lado mientras habla—. El entrenamiento se enfoca en la presencia y la escucha activa.

TIPO	Intervención conductual para TDAH en el contexto de las tareas académicas escritas
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con impulsividad en las tareas escritas — responder sin leer, saltar consignas, entregar sin revisar, errores por distracción
DURACIÓN	30 a 35 minutos
MATERIALES	Fichas de tarea con el protocolo PARA, marcadores

Objetivo

Instalar una secuencia conductual estructurada (protocolo PARA) que cree pausas deliberadas en los puntos críticos de las tareas escritas donde la impulsividad del TDAH produce más errores. Los niños con TDAH cometen muchos errores en tareas escritas no por no saber el contenido, sino por problemas ejecutivos: no leer la consigna completa, no planificar antes de escribir, no revisar al terminar. El protocolo PARA (Pará, Attendé, Realizá, Analizá) instala una pausa forzada en cada uno de esos puntos, reduciendo los errores por distracción que resultan tan frustrantes para el niño, los padres y los docentes.

Cómo aplicar

1

Presentación del protocolo PARA (10 min)

Explique cada paso con ejemplos concretos: **PARÁ**: antes de empezar cualquier tarea, pará 5 segundos. Poné las manos sobre la mesa. Todavía no escribas. **ATENDE**: leé la consigna entera con calma. Si no entendés alguna palabra, subrayala. Si la pregunta tiene más de una parte, numerá cada parte. **REALIZÁ**: ahora empezá a responder, pero con la consigna siempre a la vista. **ANALIZÁ**: al terminar, releé lo que escribiste comparándolo con lo que pedía la pregunta. ¿Estás respondiendo lo que te preguntaron?

2

Ensayo en sesión (15 min)

Traiga algunos ejercicios simples y haga que el niño aplique el PARA en voz alta, verbalizando cada paso mientras lo ejecuta. La verbalización externaliza el proceso y entrena la secuencia. El niño hace 3 a 5 preguntas con el protocolo en sesión antes de llevarlo a casa.

3

Tarjeta de bolsillo (5 min)

Cree una tarjeta pequeña con las cuatro letras de PARA y una frase para cada una. El niño la lleva en la mochila y la coloca sobre la mesa durante las tareas, hasta que el protocolo se automatice.

Lectura clínica

Observe en qué etapa del PARA el niño más «saltea». La etapa más saltada es el diagnóstico del punto de mayor impulsividad en la tarea escrita. Un niño que saltea el ATENDÉ (no lee la consigna) tiene impulsividad motora para iniciar. Un niño que saltea el ANALIZÁ (no revisa) tiene dificultad para sostener la atención hasta el final y/o baja tolerancia a lo que percibe como tarea concluida. Cada patrón requiere reforzar de forma diferenciada qué etapa del protocolo trabajar más.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué letra del PARA es la que más te olvidás de hacer?
- ¿Qué sentís cuando tenés que esperar en el PARA antes de empezar?
- ¿Alguna vez te equivocaste en algo que sabías, solo porque no leíste bien la consigna?
- Cuando revisás lo que escribiste, ¿lográs encontrar tus propios errores?
- ¿Cuánto tiempo solés dedicarle a cada parte del PARA?

Adaptaciones

Para pruebas con tiempo limitado: acuerde que el tiempo de aplicar el PARA se compensa con el tiempo que ahorra en errores y en rehacer. La inversión de 30 segundos en el PARA ahorra minutos de corrección y notas bajas por distracción.

Para niños con dificultad de lectura asociada: adapte el ATENDÉ para incluir la lectura en voz alta o subvocal de la consigna; el canal auditivo compensa la dificultad de procesamiento visual del texto.

TIPO	Instrumento de monitoreo clínico longitudinal adaptado para TDAH
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Uso sistemático a lo largo de todo el acompañamiento — evaluación de proceso y de resultado
DURACIÓN	10 a 15 minutos al inicio de cada sesión
MATERIALES	Ficha de termómetro con tres dimensiones: atención, impulsividad y regulación emocional

Objetivo

Monitorear de forma sistemática, visual y longitudinal las tres dimensiones centrales del TDAH a lo largo del tratamiento, permitiendo identificar en qué dimensiones hay progreso, en cuáles hay estancamiento, y si los avances en sesión se están generalizando a la vida cotidiana. El TDAH es multidimensional: un niño puede mejorar mucho en atención mientras la impulsividad permanece igual, o mejorar en el contexto clínico pero no en el escolar. Este instrumento captura esa complejidad de forma accesible para el niño, la familia y el psicólogo, orientando los ajustes del plan terapéutico.

Cómo aplicar

1

Estructura del termómetro (preparar antes de la primera aplicación)

Tres termómetros paralelos, cada uno del 0 al 10: (1) Termómetro de la Atención — 0 = no logro concentrarme en nada, 10 = logro concentrarme cuando lo necesito la mayoría de las veces; (2) Termómetro del Freno — 0 = actúo antes de pensar siempre, 10 = logro pausar la mayoría de las veces antes de actuar; (3) Termómetro de la Calma — 0 = exploto o me trabo cuando me frustro, 10 = logro manejar la mayoría de las frustraciones sin explotar.

2

Aplicación semanal al inicio de la sesión (10 min)

El niño marca los tres termómetros en relación con la semana. Para cada marca, pregunte: «¿Por qué ese número? ¿Qué pasó esta semana en esa área?». Anote los números en una tabla longitudinal. A partir de la cuarta sesión, muéstrole al niño el gráfico de evolución. Pregunte: «¿Qué notás cuando ves estos números juntos?».

3

Uso clínico de los datos (a lo largo del tratamiento)

Cuando un termómetro queda estancado por tres sesiones consecutivas mientras los otros suben, ajuste el foco de las sesiones hacia esa dimensión. Cuando todos quedan estancados a la vez, investigue factores ambientales: cambio en la escuela, estrés familiar, falta de medicación, regresión.

Lectura clínica

Observe la discrepancia entre la percepción del niño y la de la familia sobre los mismos termómetros. Aplicar la misma ficha con los padres (sobre el niño) y compararla con la autoevaluación del niño es sumamente revelador. Un niño que se evalúa consistentemente más alto que sus padres indica bajo automonitoreo o resistencia a reconocer las dificultades. Un niño que se evalúa consistentemente más bajo que sus padres indica hipercriticidad o una narrativa de fracaso internalizada de forma más intensa de lo que su conducta real justificaría.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué termómetro está más difícil para vos esta semana?
- ¿Qué pasó de distinto esta semana que explica ese número?
- Comparando con el comienzo del tratamiento, ¿qué notás?
- Si pudieras elegir qué termómetro hacer subir primero, ¿cuál sería?
- ¿Qué pondría tu familia en los termómetros de esta semana?

Adaptaciones

Para niños más pequeños (5 a 7 años): simplifique a un único termómetro de «cómo fue mi semana con el TDAH», de cara triste a cara feliz. La complejidad de tres dimensiones puede introducirse de forma progresiva.

Para acompañamientos largos (más de 6 meses): considere agregar un cuarto termómetro de «cómo me estoy sintiendo conmigo mismo», que captura el autoconcepto separado de las dimensiones del TDAH y que con frecuencia cambia de forma independiente de los síntomas.

TIPO	Ritual de cierre terapéutico con síntesis de aprendizajes y plan de mantenimiento
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Fase final del acompañamiento — cuando hay consolidación de las habilidades ejecutivas y del autoconcepto
DURACIÓN	50 a 60 minutos
MATERIALES	Todos los materiales del tratamiento + hoja del kit ejecutivo personal

Objetivo

Consolidar los logros del tratamiento en un cierre que fortalezca la identidad ejecutiva del niño —«soy alguien que aprendió a trabajar con mi cerebro, no en contra de él»— y que ofrezca un plan concreto de mantenimiento. El TDAH es un trastorno crónico: el cierre del tratamiento no significa cura, sino la adquisición de herramientas y autoconocimiento suficientes para que el niño navegue con más autonomía. El ritual de alta debe comunicarlo con claridad: «El TDAH va a seguir, pero cambiaste tu relación con él». Indicadores de preparación para el alta: el niño usa las herramientas de forma autónoma sin que el adulto se lo recuerde; generalización a múltiples contextos; autoconcepto más equilibrado; familia con una postura de andamiaje establecida.

Cómo aplicar

1

Revisión del recorrido (15 min)

Organice sobre la mesa todos los materiales producidos: el mapa del día, el semáforo, la caja de herramientas del cerebro, el panel de logros, las fichas del termómetro del TDAH a lo largo del tiempo. Recórralos con el niño: «¿Qué te acordás de cuando hicimos esto?» y «¿Este material hizo alguna diferencia en tu vida?». Deje que el niño conduzca.

2

El kit ejecutivo personal (15 min)

Proponga una hoja llamada «Mi kit ejecutivo»: «Vas a escribir las herramientas que más te funcionaron: no las que yo enseñé, sino las que sentís que ahora son tuyas». Distinga por contexto: qué uso en casa, qué uso en la escuela, qué uso cuando estoy con otras personas, qué uso cuando estoy enojado. Este kit es personalizado y es el documento que el niño se lleva para la vida.

3

La carta al yo del futuro (10 min)

Proponga que el niño escriba una carta a sí mismo para leer dentro de 1 año: «¿Qué aprendiste sobre tu cerebro? ¿Qué querés que el 'vos del futuro' recuerde cuando el TDAH se ponga difícil de nuevo?». Guarde la carta en un sobre cerrado; puede abrirse en la primera sesión de retorno, si la hubiera.

4

La conversación sobre recaída y retorno (10 min)

Sea directo: «El TDAH tiene fases. En los momentos de cambio —escuela nueva, adolescencia, más exigencias— las dificultades pueden volver más fuertes. Eso no es un fracaso del tratamiento. Es la señal de que es hora de usar más las herramientas o de buscar apoyo de nuevo». Construya un plan de retorno: qué señales indican que es momento de volver a las sesiones.

Lectura clínica

Observe cómo integra el niño la narrativa sobre el TDAH al final del tratamiento. Un niño que cierra con «aprendí a trabajar con mi forma de ser» integró el TDAH como parte de la identidad sin que sea toda la identidad: pronóstico excelente. Un niño que cierra con «ahora estoy curado» creó una expectativa irrealista que generará frustración cuando reaparezcan los síntomas. Un niño que cierra con «sigo siendo malo en todo» no integró los logros: el cierre puede ser prematuro, o la narrativa de fracaso es más resistente de lo que el tratamiento logró modificar.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué cambió en vos desde que empezamos a trabajar juntos?
- ¿Qué aprendiste sobre tu cerebro que no sabías antes?
- ¿Qué herramienta estás seguro de que vas a seguir usando?
- ¿Qué le dirías a un niño con TDAH que está empezando el tratamiento ahora?
- Cuando el TDAH se ponga difícil de nuevo, ¿cuál es el primer paso que vas a dar?

Adaptaciones

Para niños con TDAH grave que hicieron progresos reales pero todavía funcionan significativamente por debajo de lo esperado: ajuste el discurso de cierre. No comunique el alta como si las dificultades estuvieran resueltas; sea honesto sobre lo que sigue siendo un desafío y sobre la importancia del apoyo continuo, que puede venir de la escuela, la familia o retornos periódicos.

Para adolescencia inminente (niños de 9 a 10 años): incluya en el cierre una sección sobre los cambios esperables del TDAH en la adolescencia —aumento de las demandas ejecutivas, nuevas situaciones sociales, posible cuestión de la medicación—. Preparar para la próxima fase es parte de un cierre responsable.

TIPO	Análisis ambiental y construcción de soporte ecológico para la atención
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	TDAH con déficit de atención impactado por el ambiente físico — niño que se dispersa mucho más en ambientes caóticos, aulas desorganizadas o cuartos llenos de estímulos
DURACIÓN	40 a 50 minutos — análisis en sesión; implementación en casa y en la escuela con orientación a la familia
MATERIALES	Hoja de mapeo del ambiente, marcadores, cámara del celular (opcional para fotografiar el cuarto/escriptorio)

Objetivo

Desarrollar en el niño con TDAH la capacidad de identificar qué elementos del ambiente físico amplifican su dispersión y cuáles la favorecen, y de actuar sobre ellos como estrategia de autorregulación. La neurociencia del TDAH muestra que la corteza prefrontal, ya con recursos ejecutivos limitados, es especialmente vulnerable a la sobrecarga sensorial: los estímulos visuales y auditivos compiten directamente con la atención sostenida, drenando recursos que ya son escasos. Los niños con TDAH no están igualmente distraídos en todos los contextos: hay ambientes que los regulan y ambientes que los desregulan. Enseñar al niño a identificar y modificar su entorno le devuelve agencia sobre su propia atención.

Cómo aplicar

1

Mapeo de los ambientes del niño (10 min)

Identifique con el niño los principales ambientes donde necesita concentrarse: cuarto de estudio, aula, mesa de la cena. Para cada uno, pregunte: «Cuando tratás de concentrarte ahí, ¿qué te molesta o te distrae primero?». Registre sin juzgar. El niño suele saber exactamente qué lo interrumpe, solo que nunca se lo preguntaron.

2

El inventario de distractores (15 min)

Creen juntos una lista de distractores por categoría: visuales (muchos objetos sobre la mesa, TV de fondo, ventana con movimiento), auditivos (TV en otro ambiente, hermanos jugando, música con letra), internos (hambre, cansancio, preocupaciones sin resolver). Use una hoja dividida en tres columnas. Diga: «Pensá en los últimos días: ¿qué distractor apareció más veces?». Eso prioriza qué trabajar primero.

3

El radar personal (10 min)

Construyan un «radar del ambiente ideal»: «¿Cómo sería el ambiente perfecto para vos para estudiar? ¿Qué sonido tendría? ¿Qué cosas habría en la mesa? ¿Qué luz?». Ese ejercicio revela las condiciones óptimas individuales, que varían bastante: algunos se regulan mejor con música instrumental, otros necesitan silencio absoluto; algunos precisan la mesa vacía, otros usan un fidget discreto como regulador.

Plan de ajuste ambiental (10 min)

Defina con el niño tres cambios concretos y viables para el ambiente donde más estudia. Ejemplos: dejar solo el material de la tarea sobre la mesa, cerrar la puerta del cuarto, usar auriculares con música instrumental. Oriente a la familia a apoyar esos cambios sin convertirlos en castigo. Diga: «Vos vas a ser el arquitecto de tu propio espacio de foco».

Lectura clínica

Observe la facilidad con que el niño identifica sus distractores. Un niño que no logra nombrar ninguno puede tener bajo automonitoreo o haberse adaptado al caos de forma defensiva («siempre fue así, es normal»). Un niño que lista muchos con detalle tiene el autoconocimiento preservado y responderá bien a las intervenciones ambientales. Observe también si los distractores son externos (modificables) o predominantemente internos (pensamientos, preocupaciones, estados emocionales): estos últimos indican que el trabajo de regulación emocional o manejo de ansiedad debe integrarse a la intervención ambiental.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuál es el distractor que más te complica el foco hoy?
- ¿Hay algún lugar donde te concentrás mucho mejor? ¿Qué tiene de distinto?
- Si pudieras cambiar una cosa de tu cuarto de estudio ahora, ¿cuál sería?
- Cuando estás en tu ambiente ideal, ¿cómo te das cuenta de que estás concentrado?
- ¿Qué podés hacer solo para mejorar el ambiente, sin necesitar la ayuda de nadie?

Adaptaciones

Para niños que estudian en ambientes muy caóticos sin posibilidad de cambio (casas chicas, muchos hermanos): enfóquese en los distractores portátiles —auriculares, un biombo simple, una caja organizadora que va y viene con el niño—. La intervención se adapta a lo posible, no a lo ideal.

Para TDAH con hiperactividad intensa: un nivel bajo de estimulación de fondo (música instrumental suave) suele regular más que el silencio absoluto, que puede aumentar la agitación interna.

TIPO	Entrenamiento de organización verbal y control de la interrupción interna
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con pensamiento acelerado y simultáneo — niño que interrumpe no por falta de respeto, sino porque tiene varios pensamientos compitiendo a la vez y teme perder lo que quiere decir
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Papelitos (post-its), lapicera, un recipiente o cajita

Objetivo

Enseñar al niño con TDAH una estrategia concreta para manejar el fenómeno de los «pensamientos simultáneos» —múltiples ideas que llegan a la vez y compiten por expresarse, generando interrupciones, frases fragmentadas y dificultad para mantener el tema—. En el TDAH, la memoria de trabajo reducida crea la sensación de que «si no lo digo ahora, pierdo la idea», lo cual suele ser cierto. Eso produce interrupciones que se interpretan como falta de respeto pero son, en realidad, una estrategia de supervivencia cognitiva. La «Fila de la Cabeza» ofrece una alternativa externa: la idea no necesita decirse de inmediato porque está registrada en el papel y no va a desaparecer. Ese registro externo sustituye la memoria de trabajo verbal comprometida, reduce la urgencia de hablar y permite que el niño espere su turno.

Cómo aplicar

1

Psicoeducación sobre los pensamientos simultáneos (5 min)

Explique: «¿Sabés cuando tenés varias cosas para decir a la vez y te da miedo olvidarlas? Eso pasa porque tu cerebro es muy veloz: genera ideas más rápido de lo que podés hablar. Interrumpir no es mala educación, es tu cerebro tratando de no perder nada. Hoy lo vamos a resolver de otra forma».

2

Introducción de los papelitos de la fila (10 min)

Presente los papelitos: «Cada vez que tengas una idea mientras otra persona habla, no necesitás decirla: la escribís o la dibujás en un papelito y lo ponés en la fila. Cuando sea tu turno, la idea está guardada. No se va a ir». Practique en sesión: conduzca una conversación y pida que el niño use los papelitos cuando quiera interrumpir. Después de 5 minutos, abran los papelitos juntos y el niño dice todas las ideas que guardó.

3

Ensayo con situaciones reales (15 min)

Role play de situaciones que el niño trajo: la clase donde la maestra explica, la cena familiar donde todos hablan. Para cada una, ensaye el uso de los papelitos. Procese: «¿Cómo te sentiste guardando la idea en lugar de decirla?». Normalice la dificultad: «Al principio es incómodo. El cerebro cree que va a perder. Pero viste que no perdiste».

Adaptación progresiva (5 min)

Acuerde una versión mental de la fila para contextos donde el papel no entra (una prueba, un paseo): «Cuando no tengas papelito, repetí la idea una vez bajito para vos mismo: eso ayuda a mantenerla en la memoria hasta poder decirla». Oriente a la familia a validar el uso de los papelitos en casa en lugar de solo pedirle al niño que «espere».

Lectura clínica

Observe lo que el niño escribe en los papelitos durante el ensayo. Las ideas registradas revelan el contenido del flujo mental que normalmente «se filtra» como interrupción: asociaciones creativas, preguntas generadas por lo que dice el otro, recuerdos activados por el contexto. Ese material es clínicamente rico: muestra cómo procesa la información de forma asociativa y no lineal. Un niño que no logra ni registrar las ideas en los papelitos (porque ya «se fueron» cuando agarra el papel) tiene un déficit de memoria de trabajo muy intenso y puede beneficiarse de un grabador de voz como alternativa: basta con susurrar la idea.

Preguntas orientadoras

- Cuando tenés muchas ideas a la vez, ¿cómo te sentís?
- ¿Ya notaste que olvidaste una idea importante porque esperaste demasiado para decirla?
- ¿Cómo reaccionan las personas cuando interrumpís? ¿Cómo te hace sentir eso?
- Cuando guardás la idea en el papelito, ¿lográs relajarte y escuchar mejor lo que el otro dice?
- ¿En qué situación de tu vida sería más útil usar la fila de la cabeza?

Adaptaciones

Para niños muy pequeños (5 a 6 años): reemplace la escritura por un dibujo rápido o un garabato en el papelito. El acto de registrar es lo que importa, no el contenido legible.

Para contextos escolares: acuerde con la maestra que el niño pueda tener un cuadernito de papelitos sobre la mesa durante las clases. Es una adaptación razonable que puede incluirse en el informe escolar.

TIPO	Técnica de suavización de transiciones con aviso estructurado y ritual de cierre
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	TDAH con dificultad intensa de transición — colapso al parar el videojuego, resistencia a soltar el juguete, explosión cuando lo llaman a cenar en medio de un juego
DURACIÓN	35 a 45 minutos — estructura instalada en sesión; implementación continua en casa
MATERIALES	Timer visible, tarjeta de transición con tres campos: «Qué estoy haciendo», «Qué viene después», «Qué hago para terminar»

Objetivo

Desarrollar estrategias específicas para el momento de transición entre actividades, uno de los mayores focos de conflicto en la rutina de niños con TDAH. La dificultad de transición tiene dos orígenes neurobiológicos: el hiperfoco, que vuelve muy difícil salir de una actividad de alto interés, y la dificultad de cambio del foco atencional, que es la capacidad ejecutiva de desengancharse de un estímulo y reorientarse hacia otro. El resultado práctico es que los pedidos de transición abrupta generan resistencia y explosión no por berrinche, sino porque el sistema ejecutivo literalmente no tiene tiempo de procesar el cambio. El recurso instala un protocolo de aviso gradual y ritual de cierre que le da al sistema ejecutivo el tiempo que necesita para prepararse.

Cómo aplicar

1

Psicoeducación sobre la dificultad de transición (5 min)

Explique: «¿Intentaste alguna vez parar en medio de una película emocionante? Es difícil, ¿no? Para tu cerebro, cualquier actividad que estás disfrutando parece una película emocionante. Cuando te piden que pares de golpe, tu cerebro todavía está adentro. No es que no quieras obedecer: necesita un tiempo para salir. Vamos a crear ese tiempo».

2

El sistema de avisos graduales (15 min)

Presente el sistema en tres etapas: «10 minutos para terminar» (primer aviso: el niño ya sabe que la actividad va a terminar), «5 minutos» (empieza a preparar la parada), «1 minuto» (cierra la escena actual). Practique en sesión con una actividad que le guste. Oriente a la familia a usar el timer visible para los avisos —no la propia voz, que activa resistencia—. «Avisó el timer, no yo» reduce mucho el conflicto interpersonal.

3

El ritual de cierre (10 min)

Cree con el niño un ritual de 60 segundos para cerrar la actividad: guardar el juego, poner el juguete en su lugar, decir mentalmente «pausa acá, sigo después». El ritual crea un cierre simbólico que el cerebro con TDAH necesita. Diga: «Tu cerebro va a salir más fácil de la actividad si sabe que va a continuar después. No es un chau, es una pausa».

La tarjeta de transición (5 min)

Cree una tarjeta con tres campos que el niño completa antes de la transición: «Qué estoy haciendo ahora», «Qué viene después», «¿Voy a continuar lo que estaba haciendo? ¿Cuándo?». Esa tarjeta externaliza la planificación de la transición y reduce la ansiedad de «perder» la actividad.

Lectura clínica

Observe la intensidad de la resistencia a las transiciones en sesión: cuando propone cambiar de actividad durante la sesión, ¿cómo reacciona el niño? Esa observación directa es más confiable que el relato de la familia. Una resistencia muy intensa en sesión, incluso con aviso gradual, puede indicar una rigidez que va más allá del TDAH: investigue comorbilidad con rasgos de TEA o perfeccionismo. Un niño que logra transicionar con aviso en sesión pero no en casa indica que el problema no es la habilidad, sino el ambiente de implementación. Trabaje la consistencia del protocolo con la familia.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué actividad es la más difícil de parar cuando alguien te llama?
- ¿Qué sentís en el cuerpo cuando te piden que pares algo que estás disfrutando?
- ¿Alguna vez explotaste cuando te mandaron a parar algo? ¿Qué te hubiera gustado que fuera distinto?
- Cuando sabés que vas a poder volver a la actividad, ¿es más fácil parar?
- ¿El timer te ayuda más que la persona diciéndote que pares? ¿Por qué?

Adaptaciones

Para niños con hiperfoco muy intenso en videojuegos o pantallas: negocie con la familia puntos de parada naturales del juego (fin de nivel, punto de guardado) como momento de transición; eso respeta la lógica del juego y reduce la sensación de pérdida.

Para TDAH con desregulación emocional asociada: instale el recurso «El Cuerpo Habla» (recurso 11) antes de trabajar las transiciones —el niño necesita primero poder identificar la activación emocional antes de gestionar la transición—.

TIPO	Psicoeducación y reestructuración cognitiva sobre motivación y esfuerzo en el TDAH
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con una narrativa internalizada de pereza — niño que se llama a sí mismo vago, que cree que podría hacer las cosas si quisiera, con autoestima comprometida por el fracaso repetido en tareas de bajo interés
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja con una regla visual de 0 a 10, marcador, lista de tareas de la rutina del niño

Objetivo

Diferenciar —de forma concreta y basada en evidencia— la aversión a la tarea que caracteriza al TDAH de la pereza como rasgo de carácter, deshaciendo una de las narrativas más dañinas que los niños con TDAH internalizan. En el TDAH, el déficit dopaminérgico crea una asimetría motivacional profunda: las tareas de alto interés activan el sistema de recompensa con normalidad, mientras que las de bajo interés —sobre todo las repetitivas, aburridas o con recompensa lejana— no activan suficiente dopamina para sostener el esfuerzo. Eso no es una elección: es neurobiología. El niño que «puede jugar al videojuego horas pero no puede estudiar 15 minutos» no está eligiendo ser vago: responde a un sistema de recompensa que funciona de otra forma. Entender esa distinción es transformador para el autoconcepto y para la motivación terapéutica.

Cómo aplicar

1

La regla del interés (10 min)

Liste con el niño 10 tareas de su rutina (mezcle cosas que le gustan y que no). Para cada una, pida que marque en la regla de 0 a 10 cuán interesante es: «0 es lo más aburrido del mundo, 10 es tu cosa favorita». Anote las notas. Pregunte: «En las tareas con nota baja, ¿lográs hacerlas? ¿Con cuánta dificultad?».

2

La regla del esfuerzo necesario (10 min)

Para cada tarea, pida una segunda marca en la regla: el esfuerzo que necesita para completarla. Compare las dos reglas. El patrón será evidente: cuanto menor el interés, mayor el esfuerzo necesario. Explique: «Esto no es pereza. Es tu cerebro necesitando más combustible para tareas que no dan recompensa automática. Para vos, mantener el foco en una tarea aburrida cuesta mucho más que para la mayoría, no porque quieras, sino porque tu cerebro funciona así».

3

El test del interés (10 min)

Proponga un experimento en sesión: dele al niño la misma habilidad (por ejemplo, escribir palabras) en dos formatos —uno aburrido (lista de palabras al azar) y uno interesante (palabras de su tema favorito) —. Observe y cronometre. Muestre la diferencia: «¿Viste? No cambió la habilidad. Cambió el interés. Eso es evidencia de que no es pereza».

Estrategias de combustible externo (10 min)

Explique que, como el interés no siempre puede cambiarse, existen fuentes externas de combustible para las tareas aburridas: compañía (hacerla con alguien), recompensa inmediata al terminar, gamificación (convertirla en un desafío cronometrado), música de fondo, fragmentación (dividirla en partes mínimas). Construyan juntos un menú de estrategias que el niño puede elegir según la tarea.

Lectura clínica

Observe la reacción emocional del niño cuando se presenta la distinción entre aversión ejecutiva y pereza. Un niño con mucho alivio y un «entonces, ¿no soy vago de verdad?» indica que la narrativa de pereza estaba muy consolidada y generaba vergüenza significativa: es un momento terapéutico poderoso que merece tiempo de procesamiento. Un niño que rechaza la explicación («pero yo podría hacerlo si quisiera de verdad») puede estar usando la creencia de que es una elección como forma de mantener alguna sensación de control: la idea de que es neurobiológico puede amenazar su sentido de agencia. Explore esa resistencia con cuidado.

Preguntas orientadoras

- Cuando escuchás que no es pereza, ¿qué sentís?
- ¿Hay alguna tarea «aburrida» que lográs hacer más fácil cuando estás con alguien?
- ¿Qué le dirías a un amigo tuyo que se está llamando vago por no poder estudiar?
- ¿Qué estrategia de combustible externo te parece que funcionaría mejor para vos?
- Si hubieras sabido desde chiquito que no era pereza, ¿qué habría sido distinto?

Adaptaciones

Para niños con una narrativa de pereza muy rígida e internalizada: no presente la distinción de forma didáctica en la primera sesión —puede generar resistencia intelectualizada—. Empiece por el experimento del paso 3 y deje que el niño saque la conclusión solo. La evidencia experiencial es mucho más poderosa que la explicación teórica.

Para familias que refuerzan la narrativa de pereza: incluya una sesión de psicoeducación parental específica sobre la aversión ejecutiva antes o en paralelo al trabajo con el niño.

TIPO	Estructuración de rutinas de decisión para preservar recursos ejecutivos
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con agotamiento por la toma de decisiones — niño que colapsa ante decisiones pequeñas al final del día, que tarda muchísimo en elegir cosas simples, o que delega todas las decisiones al adulto
DURACIÓN	40 a 45 minutos — construcción en sesión; implementación en casa
MATERIALES	Fichas o tarjetas, cajita o sobre (el «cofre»), marcadores

Objetivo

Reducir el costo ejecutivo de la toma de decisiones repetitiva a lo largo del día, previniendo la fatiga de decisión que afecta de forma desproporcionada a los niños con TDAH. La corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y del control ejecutivo, es un recurso limitado que se agota a lo largo del día —el fenómeno conocido como «desgaste del yo» (ego depletion)—. En el TDAH ese recurso ya empieza más chico y se agota más rápido. Los niños que toman muchas decisiones pequeñas durante el día (qué comer, qué ponerse, con quién jugar, qué tarea hacer primero) llegan a la tarde y la noche con recursos de decisión casi nulos, lo que explica los colapsos en la cena, el llanto por decisiones triviales y la imposibilidad de hacer la tarea después de la escuela. El Cofre de Decisiones predice categorías de decisión recurrentes, eliminando el costo diario de tomarlas.

Cómo aplicar

1

Mapeo de las decisiones cotidianas (10 min)

Liste con el niño todas las decisiones que toma en un día típico, de la mañana a la noche. Sepárelas en dos grupos: decisiones únicas (qué hacer el fin de semana) y decisiones recurrentes (qué desayunar, qué ponerse, qué tarea hacer primero). Explique: «Cada decisión gasta un poco de energía de tu cerebro. Las recurrentes son las más derrochadoras, porque decidís lo mismo todos los días».

2

Construcción del cofre (20 min)

Para cada categoría de decisión recurrente, cree tarjetas con las opciones predecidas. Ejemplo: tarjetas de desayuno (4 opciones que el niño elige hoy para toda la semana); tarjetas de ropa (conjuntos armados el domingo para cada día); tarjetas de tarea (orden de las materias decidida una vez, repetida toda la semana). Ponga las tarjetas en el cofre. En el día a día, en lugar de decidir, el niño consulta el cofre. Diga: «Decidiste hoy. No hace falta decidir de nuevo mañana».

3

Revisión periódica del cofre (5 min)

Acuerde una revisión semanal de 10 minutos (domingo a la noche) para actualizar las tarjetas. Eso garantiza que las decisiones prehechas sigan siendo relevantes y le da al niño control sobre el sistema: no está obligado por ninguna decisión del cofre, pero puede consultarlo siempre que quiera ahorrar energía.

Lectura clínica

Observe en qué categorías de decisión el niño tiene más dificultad. Las decisiones sobre comida y ropa suelen reflejar aspectos sensoriales (sensibilidad a texturas, sabores) que pueden indicar un perfil sensorial atípico además del TDAH. Un niño que colapsa incluso en decisiones muy simples y con pocas opciones puede tener una carga aversiva emocional alta: la dificultad de decidir está siendo amplificada por ansiedad o desregulación emocional, no solo por el déficit ejecutivo. En esos casos, la intervención de regulación emocional debe ir en paralelo al cofre.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué decisión del día es la que más te cansa?
- ¿Alguna vez no pudiste decidir algo chiquito y te frustraste mucho?
- Si no tuvieras que decidir qué ponerte cada mañana, ¿cómo sería tu mañana?
- ¿Preferís tener pocas opciones o muchas opciones para elegir?
- ¿Qué pondrías primero en el cofre de decisiones?

Adaptaciones

Para niños que se resisten al cofre porque «les gusta decidir en el momento»: respételo en las categorías donde la decisión espontánea tiene bajo costo. El cofre es para las decisiones que cuestan más de lo que valen. No fuerce la automatización donde hay una preferencia genuina por la espontaneidad.

Para familias que toman todas las decisiones por el niño: oriente que el cofre debe construirlo el niño, no imponerlo el adulto. La autonomía para decidir, aunque sea limitada, es parte del desarrollo ejecutivo.

TIPO	Técnica de automonitoreo por registro escrito posterior al episodio impulsivo
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con impulsividad conductual recurrente — niño que actúa sin pensar, se arrepiente después, pero repite el mismo patrón; poco aprendizaje experiencial a partir de los propios impulsos
DURACIÓN	20 minutos de presentación en sesión; uso diario del niño
MATERIALES	Cuadernito pequeño (el diario), lapicera; opcional: stickers para las fechas

Objetivo

Construir automonitoreo a partir del registro sistemático de los episodios impulsivos, creando un banco de datos experiencial que el niño puede usar para identificar patrones, disparadores y consecuencias de sus propios impulsos. Los niños con TDAH suelen aprender poco de la experiencia de los errores —no porque no les importe, sino porque la memoria de trabajo y la memoria prospectiva (recordar el pasado para guiar el futuro) son menos eficientes—. Cada impulso es, para ellos, casi un evento aislado sin conexión clara con los anteriores. El diario del impulso crea esa conexión de forma artificial: al leer los registros anteriores, el niño logra ver patrones que la memoria interna no sostiene. Inspirado en las técnicas de automonitoreo estructurado de Barkley y en los registros de pensamiento disfuncional de la TCC, adaptados al lenguaje y la capacidad de los niños.

Cómo aplicar

1

Presentación del diario (5 min)

Presente el cuadernito con cuidado —no como castigo ni control adulto, sino como herramienta de autoconocimiento—: «Este cuaderno es solo tuyo. Nadie lo va a leer sin tu permiso. La idea es que seas un detective de tus propios impulsos: descubrir cuándo aparecen, qué los dispara, qué pasa después».

2

El formato del registro (10 min)

Enseñe un formato simple de 4 campos por registro: (1) ¿Qué pasó? (describí el impulso y lo que pasó después, sin juzgar); (2) ¿Qué estaba pasando antes? (disparador: ¿cansancio, hambre, provocación, transición?); (3) ¿Cómo te sentiste después? (1 a 10 de arrepentimiento o indiferencia); (4) ¿Qué probarías distinto? (no «debería», sino «probaría»). Practiquen completando juntos un episodio que el niño trajo de la semana.

3

Revisión de patrones en sesión (5 min recurrente)

Cada dos sesiones, abran el diario juntos e identifiquen patrones: «Mirando acá, ¿en qué situación aparece más el impulso? ¿Qué disparador está siempre antes?». Ese análisis de patrones es lo que diferencia el diario de un castigo de un instrumento de autoconocimiento real. Los patrones identificados orientan el foco de las intervenciones siguientes.

Lectura clínica

Observe la disposición del niño a registrar sus propios impulsos. Una resistencia alta puede indicar vergüenza intensa: el niño no quiere documentar evidencia de lo que percibe como fallas. Es señal de que el trabajo de autoestima y de reestructuración de la narrativa de defecto debe preceder al diario. Un niño que registra con riqueza y curiosidad tiene un automonitoreo emergente: el diario va a acelerar mucho el desarrollo de esa habilidad. Observe también si el niño registra solo los impulsos que generaron consecuencias negativas (castigo) o también los que «casi pasan» pero contuvo: estos últimos son los más ricos clínicamente.

Preguntas orientadoras

- Cuando lees lo que escribiste, ¿lográs ver algún patrón?
- ¿Qué disparador aparece más veces en tu diario?
- Escribir sobre el impulso después, ¿te ayuda a entender por qué pasó?
- ¿Hay algún registro que te sorprendió cuando lo leíste de nuevo?
- ¿Qué aprendiste sobre vos mismo mirando todos los registros juntos?

Adaptaciones

Para niños con dificultad de escritura (disgrafía, lentitud grafomotora): permita registros en forma de dibujo, voz (grabación de audio) o palabras clave en lugar de frases completas. El contenido del registro es lo que importa, no la forma.

Para niños muy pequeños (5 a 6 años): la psicóloga puede hacer el registro junto con el niño en sesión, a partir del relato verbal. El diario queda en el consultorio y se revisa en cada sesión.

TIPO	Entrenamiento de asertividad adaptado al perfil ejecutivo del TDAH
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con dificultad para decir que no — niño que cede por impulso a la presión del grupo, que no logra rechazar pedidos sin explotar, o que acepta todo y después se arrepiente
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Fichas de situación, espacio para role playing

Objetivo

Entrenar la habilidad de rechazo asertivo —decir que no de forma clara, sin agresividad y sin capitular—, especialmente desafiante para niños con TDAH por dos mecanismos: la impulsividad, que lleva a la respuesta inmediata (agresiva o de aceptación automática sin reflexión), y la dificultad de leer la presión social, que vuelve más costosa la negociación. Los niños con TDAH suelen oscilar entre dos extremos al rechazar: la explosión agresiva («¡no quiero y no lo hago!») o la capitulación impulsiva («bueno, dale», seguida de arrepentimiento). La asertividad —el punto medio que expresa el no con claridad y calma— es una habilidad ejecutiva que necesita enseñarse y ensayarse. Basado en técnicas de entrenamiento de habilidades sociales adaptadas al TDAH, con un componente de control de impulso integrado.

Cómo aplicar

1

Mapeo de las situaciones de dificultad para rechazar (5 min)

Pregunte: «¿Hay situaciones donde terminás haciendo algo que no querías porque no lograste decir que no? ¿O donde dijiste que no de un modo que generó pelea?». Identifique 2 o 3 situaciones reales. Clasifíquelas: ¿en cuáles explota y en cuáles cede sin querer? Las estrategias para cada una son distintas.

2

Las tres formas de decir que no (10 min)

Presente las tres formas de responder a un pedido: no agresivo («no lo voy a hacer y dejá de pedirme» —genera conflicto—), no pasivo («bueno» sin querer —genera arrepentimiento—), no asertivo («no quiero hacer esto ahora, pero puedo hacer otra cosa» —comunica sin agredir—). Ensaye las tres formas con la misma situación para que el niño sienta la diferencia en el cuerpo y en el resultado.

3

El guion del no asertivo (15 min)

Construya un guion de 3 pasos para situaciones de presión: (1) Pausa de 3 segundos antes de responder —«tu cuerpo quiere responder ya, pero la cabeza necesita 3 segundos»—; (2) Claridad interna —«¿quiero de verdad decir que no o estoy enojado?»—; (3) Frase asertiva —«no quiero ahora» o «no me siento bien con esto»—. Practique en role play con situaciones reales del niño: un compañero que lo presiona a participar de algo que no quiere, un hermano que insiste con un juego que no quiere jugar.

Ensayo con activación emocional (10 min)

Aumente la presión en el role play: insista aunque el niño diga que no, use un tono más apelativo («dale, solo esta vez», «sos un aburrido»). Observe si mantiene el no asertivo o si regresa a la explosión o a la capitulación. Debriefe: «¿Qué cambió cuando insistí? ¿Qué sentiste? ¿Qué quiso hacer tu cuerpo?».

Lectura clínica

La forma en que el niño reacciona a la presión en el role play es un indicador de cómo funciona en situaciones sociales reales. Un niño que mantiene el no asertivo aun con presión moderada tiene la inhibición de respuesta relativamente preservada para contextos sociales. Un niño que capitula de inmediato incluso en role play indica dificultad de tolerancia a la desaprobación, que puede tener raíz en la sensibilidad al rechazo disfórica que Barkley describe asociada al TDAH y que merece investigación específica. Un niño que explota en el role play incluso en situación de baja presión indica que la regulación emocional necesita trabajo previo al entrenamiento de asertividad.

Preguntas orientadoras

- ¿Hubo situaciones en que dijiste que sí pero querías haber dicho que no? ¿Qué te impidió decir que no?
- Cuando decís que no de forma agresiva, ¿las cosas mejoran o empeoran?
- ¿Cómo te sentís cuando lográs decir que no con calma y la persona lo acepta?
- ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando alguien insiste con un pedido que no querés hacer?
- ¿En qué situación te gustaría más lograr decir que no de forma asertiva?

Adaptaciones

Para niños con TDAH y perfil de ansiedad social: el entrenamiento del rechazo es más delicado porque la preocupación por el rechazo es más intensa. Trabaje primero la tolerancia a la desaprobación antes de practicar el no.

Para situaciones que implican presión de grupo hacia conductas de riesgo (edad escolar mayor): adapte los escenarios para incluir situaciones de riesgo real —esta habilidad de rechazo es un factor protector importante para la adolescencia—.

TIPO	Psicoeducación y estructuración de una rutina de sueño para TDAH
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	TDAH con dificultades significativas de inicio y mantenimiento del sueño — niño que no logra «apagarse» a la noche, que tarda mucho en dormir, que se despierta seguido, con impacto diurno en los síntomas
DURACIÓN	40 a 50 minutos — estructuración en sesión; implementación con orientación a la familia
MATERIALES	Hoja de rutina nocturna, marcadores; opcional: timer visible para el ritual del sueño

Objetivo

Estructurar una rutina de sueño que compense las dificultades específicas que el TDAH genera en la regulación circadiana y en el desenganche del sistema de activación. Las investigaciones indican que el 70 a 80% de los niños con TDAH presenta alguna dificultad de sueño —no solo como comorbilidad, sino como consecuencia directa de los déficits ejecutivos y de la desregulación dopaminérgica—. El cerebro con TDAH tiene dificultad para «apagarse» a la noche por dos mecanismos: (1) pensamientos acelerados que no cesan cuando el ambiente se aquieta; (2) dificultad para inhibir la búsqueda de nuevos estímulos (un episodio más, una partida más). La privación de sueño, a su vez, empeora directamente las funciones ejecutivas, creando un círculo vicioso: el TDAH causa mal sueño, y el mal sueño empeora el TDAH. Intervenir en el sueño es intervenir directamente en los síntomas diurnos.

Cómo aplicar

1

Evaluación del patrón de sueño actual (10 min)

Mapee con el niño y la familia: a qué hora se va a la cama, cuánto tarda en dormirse, si se despierta durante la noche, cómo despierta a la mañana. Pregunte: «¿Qué hacés en la última hora antes de dormir? ¿En qué se queda pensando tu cabeza cuando apagás la luz?». Ese mapeo identifica los puntos específicos de intervención.

2

Psicoeducación sobre sueño y TDAH (10 min)

Explique con lenguaje concreto: «Tu cerebro con TDAH necesita una ayuda especial para entrar en modo dormir, porque es muy bueno para quedarse despierto y prestar atención a cosas nuevas. Sin una rutina específica, no recibe la señal de que es hora de desacelerar». Compárelo con una computadora que necesita un proceso específico de apagado para no colgarse.

3

Construcción del ancla del sueño (15 min)

Construya una rutina nocturna de 30 a 45 minutos con el niño; cada etapa desacelera un poco más el sistema nervioso. Secuencia sugerida: baño tibio (baja la temperatura corporal, señal fisiológica de sueño), luces más tenues (reduce el estímulo visual), actividad calmante de baja estimulación (un libro, un dibujo tranquilo, sin pantalla), «descarga mental» de 5 minutos (el niño dice o escribe los pensamientos de la cabeza antes de dormir, vaciando la memoria de trabajo). La secuencia es el ancla: el cerebro aprende que esa secuencia significa sueño.

Gestión de pantallas (5 min)

Oriente sobre las pantallas: la luz azul suprime la melatonina y el contenido estimulante activa el sistema de búsqueda dopaminérgico —justo lo opuesto de lo que el cerebro con TDAH necesita antes de dormir—. Regla práctica: pantallas apagadas 60 minutos antes de la hora de dormir. Ayude a la familia a negociar esa transición usando el sistema de aviso gradual del recurso 23.

Lectura clínica

Observe la calidad del sueño que relata la familia en correlación con la intensidad de los síntomas en las sesiones. Sesiones en que el niño está mucho más disperso, irritable o impulsivo que lo habitual pueden estar relacionadas con una mala noche de sueño: pregunte siempre por el sueño cuando la sesión está atípicamente difícil. En niños con TDAH que usan medicación estimulante y tienen dificultades de sueño: investigue si la dificultad es previa al medicamento o si el efecto rebote de la medicación está interfiriendo en el inicio del sueño. Ese dato es importante para comunicar al médico responsable.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué te pasa por la cabeza cuando apagás la luz e intentás dormir?
- ¿Hay algo que hacés que te ayude a relajarte antes de dormir?
- ¿Cómo estás al día siguiente cuando no dormiste bien?
- ¿Qué es lo que más te cuesta soltar para irte a dormir?
- Si durmieras mejor todas las noches, ¿qué te parece que sería distinto en tus días?

Adaptaciones

Para niños con pensamientos acelerados muy intensos al acostarse: el diario nocturno de 5 minutos (escribir o grabar todos los pensamientos antes de dormir) es muy eficaz —externaliza la memoria de trabajo y reduce la rumiación—.

Para niños que ya tienen rutina de sueño pero aun así tardan mucho en dormirse: investigue la ansiedad nocturna como factor separado del TDAH; puede haber un componente ansioso que requiera intervención específica.

TIPO	Entrenamiento de atención auditiva y memoria de trabajo auditiva con estructura de juego
EDAD	5 a 9 años
DEMANDA	TDAH con dificultad de atención auditiva — niño que no procesa lo que oye en clase, que pierde instrucciones verbales, que parece no escuchar aun sin intención
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Historias cortas preparadas por la psicóloga, fichas de preguntas, sistema de puntos simple

Objetivo

Entrenar la atención auditiva sostenida y la memoria de trabajo auditiva —dos habilidades que impactan directamente el desempeño escolar de los niños con TDAH, que a menudo pierden información verbal no porque no oigan, sino porque el procesamiento auditivo no sostiene la información el tiempo suficiente para usarla—. La distinción es fundamental: un niño que no oye tiene un problema auditivo; un niño con TDAH que no procesa lo que oyó tiene un déficit de atención auditiva y de memoria de trabajo —dos déficits ejecutivos distintos—. El entrenamiento gamificado aumenta la motivación y da refuerzo inmediato, que es a lo que mejor responde el sistema dopaminérgico del TDAH. Basado en el modelo de entrenamiento de atención auditiva de Barkley y en técnicas de entrenamiento de la memoria de trabajo para TDAH.

Cómo aplicar

1

Calibración de la atención auditiva actual (5 min)

Lea una historia de 3 o 4 frases y haga 3 preguntas simples sobre el contenido. Esa calibración inicial (sin avisar que va a haber preguntas) revela el nivel basal de atención auditiva. Después, lea una segunda historia avisando que habrá preguntas y compare los resultados. La diferencia entre las dos condiciones es clínicamente relevante: si mejora mucho con el aviso, el déficit es de atención selectiva; si no mejora, puede haber un componente de procesamiento auditivo.

2

Estructura del juego de la escucha (20 min)

Reglas del juego: usted lee una historia o instrucción de longitud creciente. Después de oírla, el niño responde preguntas para ganar puntos. Empieza con historias de 2 o 3 frases y 2 preguntas. Aumenta progresivamente en longitud y complejidad a lo largo de las semanas. Variaciones que suben la dificultad: agregar distractores visuales mientras lee; usar volumen de voz variable; incluir información secundaria que no se pregunta. Diga: «Tu misión es capturar todo lo que yo diga y guardarlo en la cabeza».

3

Estrategias de escucha activa (10 min)

Enseñe estrategias concretas para aumentar la retención auditiva: repetición interna («mientras escucho, repito mentalmente las partes más importantes»), anclaje visual («imagino lo que escucho como una película»), y gesticulación discreta («muevo el dedo contando los puntos principales»). Practique cada estrategia con una historia corta. El niño identifica cuál le funciona mejor.

Lectura clínica

Distinga con cuidado el déficit de atención auditiva del trastorno del procesamiento auditivo central (TPAC), una condición separada del TDAH pero que a menudo coexiste. Un niño con TPAC suele tener dificultad auditiva aun en condiciones de altísima atención y con material simple: el problema está en el procesamiento neurológico del sonido, no en la atención. Si hay sospecha de TPAC (niño que pide repeticiones constantemente, confunde fonemas parecidos, tiene dificultad desproporcionada en ambientes con ruido de fondo), derive a evaluación fonoaudiológica especializada.

Preguntas orientadoras

- Cuando estás en clase, ¿qué te distrae más: lo que ves o lo que oís?
- ¿Podés repetir lo que dije hace 3 frases ahora?
- ¿Qué estrategia de escucha te ayudó más: repetir mentalmente, imaginar o contar con los dedos?
- Cuando la maestra da una instrucción larga, ¿qué hacés para no perderla?
- ¿En qué situación perdés más lo que oís: cuando hay ruido, cuando es largo, o cuando es aburrido?

Adaptaciones

Para niños con TDAH de déficit de atención predominante: el juego de la escucha es especialmente relevante porque el perfil inatento compromete mucho más la atención auditiva que la hiperactividad. Invierta más sesiones en este recurso con ese perfil.

Para niños con dificultades de lenguaje asociadas: simplifique el contenido de las historias y reduzca el número de preguntas. El objetivo es entrenar la atención, no evaluar la comprensión lingüística.

TIPO	Entrenamiento de autorregulación de la comunicación verbal con feedback en tiempo real
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con habla muy acelerada, volumen inadecuado al contexto, intensidad comunicativa desproporcionada que aleja a los pares y genera conflictos en clase
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Tarjeta con un velocímetro dibujado (lento/medio/rápido), grabador de voz (celular), auriculares

Objetivo

Desarrollar la conciencia y la regulación de la propia comunicación verbal —velocidad, volumen e intensidad—, a menudo desregulada en el TDAH como consecuencia de la hiperactividad verbal y del déficit de automonitoreo. Los niños con TDAH hablan más rápido, más fuerte y con más intensidad de lo que el contexto social pide, no por elección, sino por un déficit del sistema de monitoreo interno que calibra la comunicación en tiempo real. El resultado social es significativo: se los percibe como invasivos, dominadores o irritantes, lo que agrava el rechazo social. El recurso usa el principio del feedback auditivo diferido —el niño se escucha y calibra— combinado con un ancla visual (el velocímetro) para instalar un punto de referencia externo que sustituye el automonitoreo interno deficitario.

Cómo aplicar

1

Demostración del contraste (10 min)

Grabe un tramo de conversación natural en sesión sin avisar que lo usará para analizar la voz. Después, muestre el velocímetro: lento (voz de biblioteca, ritmo de narrador de documental), medio (conversación normal entre amigos), rápido (emergencia, animación extrema). Escuchen juntos el tramo grabado: «¿En qué velocidad te parece que estabas?». Después compare con su percepción. La discrepancia entre autopercepción y realidad es el dato de partida.

2

Entrenamiento de ajuste en tiempo real (20 min)

Conduzca una conversación con el niño con la tarjeta del velocímetro visible sobre la mesa. Durante la charla, señale con discreción el velocímetro cuando el ritmo o el volumen cambien —sin interrumpir, solo el gesto—. Observe si el niño logra ajustar en el momento. Alterne contextos: «Ahora hacé de cuenta que estamos en una biblioteca» (lento), «Ahora en una fiesta» (medio-rápido), «Ahora contando una noticia urgente» (rápido). El entrenamiento del cambio intencional de velocidad instala el control que normalmente es automático.

3

Señal de anclaje personal (5 min)

Defina con el niño un gesto discreto que pueda usar consigo mismo cuando note que está acelerado —un toque en el cuello, una respiración larga—. acuerde también una señal entre ustedes para cuando usted lo note en sesión: «Cuando yo haga así, es para que chequees el velocímetro. No es crítica, es recordatorio».

Lectura clínica

Observe la diferencia de velocidad y volumen del niño en momentos de alta activación emocional versus momentos neutros. La desregulación verbal en el TDAH es mucho más intensa en estados de excitación positiva o negativa: no es constante. Eso significa que la intervención debe enfocarse especialmente en los disparadores de hiperactivación, no en la conducta de base. Un niño que logra regular la voz en sesión individual pero no en grupo indica que la dificultad es de carga de estimulación social: el entrenamiento debe aproximarse gradualmente a contextos grupales para generalizar.

Preguntas orientadoras

- ¿Ya notaste que estabas hablando muy fuerte y no te diste cuenta hasta que alguien te lo dijo?
- ¿En qué situación hablas más rápido: cuando estás entusiasmado, cuando estás nervioso, o siempre?
- ¿Cómo reaccionan las personas cuando hablas muy rápido o muy fuerte?
- ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando bajas la velocidad del habla? ¿Se siente raro?
- ¿Hay alguna persona cuya voz admiras? ¿Qué hace que te gustaría aprender?

Adaptaciones

Para niños con TDAH y tartamudez asociada: no trabaje la velocidad del habla sin coordinación con fonoaudiología —la intervención en el ritmo del habla en niños con tartamudez tiene protocolos específicos—.

Para niños con dificultad de volumen en contextos específicos (solo en la escuela, solo en grupo): el problema puede ser de regulación contextual, no de volumen de base. Trabaje la lectura de las señales sociales del contexto antes de trabajar la modulación de la voz.

TIPO	Instrumento de registro y transferencia de aprendizajes de la sesión a la vida cotidiana
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Uso sistemático a lo largo de todo el acompañamiento — especialmente cuando las habilidades entrenadas en sesión no se están generalizando al día a día
DURACIÓN	10 a 15 minutos al inicio y al final de cada sesión
MATERIALES	Hoja del Puente (preparada por la psicóloga), lapicera

Objetivo

Estructurar la transferencia de los aprendizajes de la sesión al contexto cotidiano del niño, el principal desafío clínico en el tratamiento del TDAH. Lo que se entrena en el consultorio a menudo no se generaliza automáticamente a casa y la escuela —sobre todo en niños con TDAH, con dificultad de memoria prospectiva (recordar usar una habilidad aprendida en el contexto y el momento correctos)—. El Puente entre Sesiones crea una estructura explícita para eso: al final de cada sesión, el niño define qué va a intentar aplicar en la semana, cómo y cuándo; al inicio de la siguiente, lo revisan juntos. Ese ciclo intención-acción-revisión es el núcleo del aprendizaje ejecutivo transferible.

Cómo aplicar

1

Final de la sesión: construcción del puente (7 min)

En los últimos 7 minutos de cada sesión, pida que el niño complete tres campos: (1) «¿Qué aprendí o entrené hoy?» (en palabras suyas, no suyas de usted); (2) «¿Dónde y cuándo lo voy a intentar esta semana?» (específico: no «voy a intentar en casa», sino «el jueves cuando la maestra dé la tarea»); (3) «¿Quién me puede ayudar a acordarme?» (un aliado real: mamá, papá, hermano). La hoja va a casa con el niño.

2

Inicio de la sesión siguiente: revisión del puente (7 min)

En los primeros 7 minutos de la sesión siguiente, revisen la hoja juntos: «¿Qué pasó cuando lo intentaste? ¿Funcionó? ¿Qué lo complicó?». No hay juicio si no lo intentó; hay curiosidad: «¿Qué te lo impidió?». Ese dato orienta los ajustes de la intervención. El niño que intentó y no pudo aporta información sobre barreras; el que no intentó, sobre el compromiso y la motivación con la tarea.

3

Acumulación de puentes a lo largo del tratamiento (continuo)

Guarde todas las hojas en orden cronológico. Cada 4 a 6 semanas, revise los puentes acumulados con el niño: «Mirando todas estas semanas, ¿qué fue lo que más intentaste? ¿Qué funcionó mejor? ¿Qué dejaste de intentar?». Ese análisis longitudinal es una de las herramientas más ricas de evaluación de proceso: revela qué habilidades se internalizaron de verdad y cuáles quedan solo en el nivel del consultorio.

Lectura clínica

La tasa de intento del niño semana a semana es un indicador de compromiso terapéutico y de validez ecológica de las intervenciones. Un niño que consistentemente no intenta aplicar las habilidades entrenadas puede estar encontrando los objetivos irrelevantes o inalcanzables, o puede tener una barrera ambiental (familia que no apoya, escuela que castiga) que hay que abordar. El puente revela ese dato antes de que ocurra el abandono terapéutico. Observe también la calidad del relato al retornar: la riqueza de detalles indica que realmente intentó y observó; la vaguedad («intenté pero no funcionó») indica que puede no haberlo intentado o que el automonitoreo es insuficiente para relatar.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué recordás haber aprendido la semana pasada que intentaste usar fuera de acá?
- ¿Qué te impidió intentar usar la habilidad que acordamos?
- Cuando lo intentaste y funcionó, ¿qué fue distinto de lo que esperabas?
- ¿Qué persona de tu vida te ayudó más a acordarte de usar lo que entrenamos?
- Si pudieras cambiar una cosa de lo que entrenamos para que sea más fácil de usar afuera, ¿qué sería?

Adaptaciones

Para niños muy pequeños (4 a 6 años): simplifique el puente a un único campo: «Lo que voy a intentar esta semana», con un dibujo. El retorno en la sesión siguiente es oral.

Para niños que se olvidan la hoja en casa consistentemente: fotografíe la hoja en el celular junto con el niño antes de que se vaya —la foto en el celular del niño o de los padres sirve de recordatorio—. Eso también es una intervención de memoria prospectiva.

TIPO	Análisis de errores académicos para identificar qué función ejecutiva está fallando
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con desempeño académico por debajo del potencial intelectual — niño que se equivoca por descuido, que no termina las pruebas, que pierde puntos por no leer la consigna, que sabe el contenido pero no lo demuestra en la evaluación
DURACIÓN	40 a 45 minutos — análisis de pruebas y tareas traídas por la familia
MATERIALES	Pruebas y tareas recientes del niño, lápices de colores, hoja de análisis de errores

Objetivo

Desarrollar con el niño y la familia un análisis sistemático de los errores académicos desde una lente ejecutiva —identificando qué función ejecutiva específica falla en cada tipo de error, en lugar de interpretarlos todos como «no estudió» o «no prestó atención»—. En el TDAH, los errores académicos tienen orígenes ejecutivos distintos: errores por no leer la consigna (impulsividad de inicio), errores de cálculo en problemas que sabe hacer (atención sostenida insuficiente), preguntas dejadas en blanco que sabía responder (gestión del tiempo), respuestas correctas pero incompletas (memoria de trabajo y monitoreo). Cada tipo requiere una intervención distinta. Este análisis transforma la devolución de una nota baja —a menudo traumática para el niño con TDAH— en una investigación científica con plan de acción.

Cómo aplicar

1

Recolección del material (previo a la sesión)

Pida a la familia que traiga 2 o 3 pruebas o tareas recientes con errores, preferentemente de materias distintas. Pida también las notas y cualquier comentario de la maestra. No pida que el niño prepare nada: trae el material como está.

2

Categorización de los errores (15 min)

Con el niño, analice cada error y categorícelo por colores: rojo (error por no leer la consigna), naranja (descuido en un cálculo o escritura que sabe hacer), amarillo (pregunta dejada en blanco que sabe), azul (error de contenido que genuinamente no sabe). Concluya: «De todos estos errores, ¿cuántos son de contenido? ¿Y cuántos son de cómo hiciste la prueba?». Ese dato suele ser revelador: la mayoría de los errores suele ser ejecutiva, no de contenido.

3

Identificación del patrón dominante (10 min)

Identifique el color que más aparece: esa es la función ejecutiva prioritaria a trabajar. Si domina el rojo: trabaje el protocolo PARA (recurso 18). Si domina el naranja: trabaje la revisión y el automonitoreo. Si domina el amarillo: trabaje la gestión del tiempo en la prueba. Diga: «No te estás equivocando por no saber. Te estás equivocando por cómo tu cerebro usa el tiempo y la atención durante la prueba. Eso lo podemos entrenar».

Plan de acción específico (10 min)

Para el patrón dominante identificado, construyan juntos un plan de una acción específica para la próxima prueba. Pequeña, concreta, verificable: «En todas las preguntas, lee la consigna dos veces antes de escribir nada». Acuerden una forma de chequear si se hizo.

Lectura clínica

Observe la reacción emocional del niño cuando se categorizan los errores. Un niño con mucha vergüenza al ver sus propios errores puede tener dificultad para mantener la postura investigativa: la vergüenza colapsa el proceso analítico. Valide el sentimiento antes de seguir: «Sé que ver los errores es difícil. Pero acá no te están juzgando, te están investigando». Un niño que naturaliza todos los errores como inevitables («siempre fue así») puede haber internalizado tan profundamente la narrativa de fracaso que perdió la creencia de que puede mejorar: trabaje la autoeficacia antes del análisis técnico.

Preguntas orientadoras

- Mirando estos errores, ¿cuál es el que más te frustra?
- ¿Sabías la respuesta de alguna pregunta que erraste o dejaste en blanco?
- Durante la prueba, ¿por lo general te sobra tiempo o el tiempo se acaba antes?
- ¿Qué te parece que podría cambiar en la forma de hacer la prueba que haría diferencia en la nota?
- Si la maestra viera cómo estudiaste en vez de solo el resultado, ¿qué vería?

Adaptaciones

Para niños con muchos errores de contenido (azul dominante): el problema no es exclusivamente ejecutivo —hay lagunas de aprendizaje que necesitan intervención pedagógica específica—. Considere una evaluación de dificultades de aprendizaje específicas (dislexia, discalculia) si el patrón persiste tras las intervenciones ejecutivas.

Para familias que usan las notas como medida central del éxito: use los datos del laboratorio para ampliar el marco de referencia —la distribución de errores es más informativa que la nota final—.

TIPO	Intervención psicoeducativa estructurada para padres — manejo del comportamiento y relación parental
EDAD	Padres de niños de 4 a 10 años con TDAH
DEMANDA	Familia con alto nivel de conflicto en torno al TDAH — padres que discrepan en el abordaje, que alternan entre la sobreindulgencia y los castigos excesivos, o que están agotados emocionalmente
DURACIÓN	60 minutos — sesión exclusiva con los padres, sin el niño
MATERIALES	Hoja de psicoeducación para padres, lista de estrategias de manejo, lectura recomendada

Objetivo

Ofrecer a los padres una sesión estructurada de psicoeducación sobre TDAH y manejo conductual que reduzca el conflicto familiar y alinee los abordajes de los cuidadores. La investigación sobre el tratamiento del TDAH —incluido el estudio MTA, el mayor ensayo clínico sobre el tema— demuestra de forma consistente que el entrenamiento parental es uno de los componentes de mayor efecto, comparable a la medicación en muchos resultados conductuales. Las familias con cuidadores desalineados —uno permisivo, otro autoritario; uno que cree en el diagnóstico, otro que no— producen un ambiente impredecible que agrava los déficits ejecutivos del niño, que depende de la consistencia ambiental para compensar la inconsistencia interna. El recurso no reemplaza el entrenamiento parental estructurado (como el protocolo de Barkley), pero ofrece una primera sesión de alineamiento que suele ser transformadora.

Cómo aplicar

1

Bloque 1 — Validación del agotamiento parental (10 min)

Antes de cualquier información, valide: «Criar a un niño con TDAH es genuinamente más difícil que criar a un niño sin TDAH; las investigaciones muestran que los padres de niños con TDAH tienen tasas mucho mayores de estrés, depresión y conflicto conyugal. No están haciendo las cosas mal. Están haciendo mucho con pocos recursos». Ese encuadre abre a los padres a recibir las estrategias sin ponerse a la defensiva.

2

Bloque 2 — Los tres mitos más dañinos sobre el TDAH en la familia (15 min)

Presente y deshaga los tres mitos que más generan conflicto familiar: (1) «Podría controlarse si quisiera» —explique la neurobiología del control ejecutivo—; (2) «Es falta de límites» —distinga el déficit ejecutivo del déficit de disciplina—; (3) «La medicación lo resuelve todo» —explique que la medicación es un componente del tratamiento, no un sustituto de las estrategias conductuales y ambientales—. Para cada mito, escuche la posición de los padres antes de presentar la información.

3

Bloque 3 — Las cinco estrategias de mayor impacto (20 min)

Presente cinco estrategias basadas en evidencia para el día a día: (1) Instrucciones cortas y en partes —no cadenas largas de pedidos—; (2) Consecuencias inmediatas —el cerebro con TDAH no aprende de consecuencias lejanas—; (3) Consistencia entre cuidadores —las mismas reglas de ambos lados—; (4) Ratio de positivo a negativo —cinco elogios específicos por cada crítica (investigación de John Gottman sobre relaciones funcionales)—; (5) Preservar la relación —separar el comportamiento del niño de su identidad—.

4

Bloque 4 — El plan de alineamiento (10 min)

Identifique el punto de mayor conflicto entre los cuidadores (por lo general una situación específica: la hora de la tarea, la cena, el momento de dormir) y construyan juntos una respuesta acordada para esa situación —no la respuesta perfecta, sino una que ambos puedan sostener con consistencia—.

Lectura clínica

Observe la dinámica entre los cuidadores durante la sesión. Un cuidador que interrumpe, corrige o descalifica al otro está revelando un patrón que ocurre en casa y que el niño experimenta a diario. No lo confronte directamente en la primera sesión: obsérvelo y úselo como información para el manejo de la sesión (dé espacio igual a ambos, valide perspectivas distintas). Un cuidador que llora o expresa un agotamiento intenso merece un espacio de contención antes de la psicoeducación —los padres agotados no absorben estrategias—. Considere la derivación a apoyo individual del cuidador cuando el agotamiento es severo.

Preguntas orientadoras para los padres

- ¿Cómo reaccionan normalmente de forma distinta cuando [nombre del niño] tiene una crisis?
- ¿Qué momento del día es el más difícil para la familia en conjunto?
- Cuando están alineados en qué hacer, ¿qué cambia en el comportamiento del niño?
- ¿Qué necesitarían más para sentirse menos solos en este proceso?
- ¿Qué les gustaría que su hijo supiera sobre cómo se sienten?

Adaptaciones

Para familias con un solo cuidador presente: adapte el foco al manejo individual y a la construcción de una red de apoyo (abuelos, tíos, escuela). La ausencia de un segundo cuidador no elimina la necesidad de consistencia: esta debe venir de otros contextos de vida del niño.

Para familias en situación de separación con coparentalidad conflictiva: no intente resolver el conflicto conyugal en la sesión sobre TDAH. Enfóquese en lo posible en cada casa por separado, con una consistencia mínima entre los hogares.

TIPO	Técnica de gamificación para superar el bloqueo de inicio en el TDAH
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con dificultad intensa de inicio de tareas — procrastinación extrema, parálisis ante tareas no preferidas, niño que pasa horas sin empezar la tarea aun sin ninguna otra actividad compitiendo
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Timer visible, ficha de misión (misión, tiempo, recompensa), stickers o fichas de puntos

Objetivo

Superar el bloqueo de inicio —uno de los síntomas más incapacitantes del TDAH y de los menos comprendidos por padres y docentes— mediante una estructura gamificada que activa el sistema dopaminérgico de recompensa inmediata. La dificultad de inicio en el TDAH no es procrastinación voluntaria: es un déficit del sistema de activación motivacional que vuelve extremadamente difícil empezar una tarea sin interés inmediato o presión externa. El niño no está «esperando las ganas»: genuinamente no logra generar el impulso de inicio sin un disparador externo. El recurso transforma la tarea aversiva en una «misión imposible» con reglas claras, tiempo limitado y recompensa inmediata —todos elementos que activan el sistema dopaminérgico lo suficiente para superar el bloqueo—. Basado en el principio de las «intenciones de implementación» de Gollwitzer, adaptado al perfil motivacional del TDAH.

Cómo aplicar

1

Psicoeducación sobre el bloqueo de inicio (5 min)

Explique: «¿Alguna vez te quedaste mirando la tarea sin poder empezar, aunque querías terminarla? Eso tiene un nombre: es el bloqueo de inicio. Tu cerebro necesita un empujón para empezar tareas que no son interesantes. No es pereza, es cómo funciona el motor. Hoy vamos a crear ese empujón».

2

Estructura de la misión (15 min)

Cree la ficha de misión para una tarea aversiva real del niño. La ficha tiene: nombre de la misión (convierta la tarea en una misión temática: «Operación Matemática»), objetivo exacto (no «hacer la tarea», sino «5 problemas de matemática»), tiempo disponible (timer de 15 minutos), recompensa inmediata (qué gana al terminar en el tiempo). Presente: «Tu misión, si decidís aceptarla, es [objetivo] en [tiempo]. La recompensa es [recompensa]. ¿Aceptás?». El ritual de aceptación de la misión es parte de la activación.

3

La regla de los 2 minutos (5 min)

Enseñe la regla de los 2 minutos para usar fuera de la sesión: «Antes de cualquier tarea que estás evitando, comprométe solo con 2 minutos. Solo 2 minutos. Si después de esos 2 minutos todavía querés parar, podés. Pero probablemente no vas a querer, porque empezar es el peor momento, y después de 2 minutos el inicio ya pasó». Eso usa el principio de que la inercia de la acción supera a la inercia del reposo.

Práctica en sesión (10 min)

Aplique la misión en sesión con una tarea real que el niño trajo. Ponga el timer, entregue la ficha de misión, acompañe sin interferir. Al final, procese: «¿Cómo fue? ¿Cuánto te ayudó la misión a empezar? ¿Qué fue distinto de cuando intentás empezar solo?».

Lectura clínica

Observe si el bloqueo de inicio es específico de las tareas académicas o generalizado a cualquier tarea no preferida. Un bloqueo muy generalizado (niño que no logra iniciar ninguna actividad sin empujón externo, incluidas actividades de ocio que él eligió) puede indicar un cuadro de depresión superpuesto al TDAH — la anhedonia dificulta el inicio incluso de las actividades placenteras—. Ese dato es clínicamente crítico y requiere evaluación específica. Un niño que logra iniciar actividades de interés sin dificultad pero se paraliza por completo en las tareas académicas tiene un bloqueo selectivo, típico del TDAH puro sin comorbilidad depresiva.

Preguntas orientadoras

- Cuando vas a hacer la tarea y no lográs empezar, ¿qué te pasa por la cabeza?
- ¿Hay alguna tarea que antes te parecía aburrida pero ahora lográs empezar más fácil? ¿Qué cambió?
- Cuando alguien empieza la tarea con vos por 2 minutos, ¿se hace más fácil seguir solo?
- ¿Cuál fue la última misión que completaste en el tiempo acordado? ¿Cómo te sentiste?
- ¿Qué te ayuda más a empezar una tarea difícil: el timer, la recompensa o la misión temática?

Adaptaciones

Para bloqueos muy intensos donde ni la misión gamificada resuelve: el problema puede estar en la tarea en sí —un nivel de dificultad incompatible con la habilidad actual, que genera evitación por anticipación de fracaso—. Antes de intensificar la estrategia de inicio, evalúe si la tarea necesita modificarse (simplificarse, fragmentarse, apoyarse).

Para niños que usan la misión pero paran antes del timer: trabaje la tolerancia a la frustración antes de ampliar las misiones.

TIPO	Psicoeducación y entrenamiento de la flexibilidad entre modos cognitivos
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con pensamiento creativo muy activo que interfiere en tareas que exigen secuencia y estructura — o, al contrario, TDAH con rigidez cognitiva que bloquea la creatividad como punto fuerte
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja con dos personajes: el Robot (estructurado, secuencial) y el Artista (asociativo, creativo), marcadores

Objetivo

Desarrollar en el niño con TDAH la conciencia de dos modos cognitivos distintos —el pensamiento estructurado y secuencial (útil en tareas académicas, planificación, seguir instrucciones) y el pensamiento asociativo y creativo (el modo que el TDAH suele turboalimentar)— y la habilidad de alternar de forma intencional entre ellos según lo que pida la situación. Los niños con TDAH suelen tener una creatividad excepcional y un pensamiento lateral por encima de la media, pero operan predominantemente en el modo creativo-asociativo, lo que interfiere en las tareas que exigen el modo estructurado. La metáfora del Robot y el Artista no jerarquiza los dos modos —ambos tienen valor— pero instala la conciencia de que situaciones distintas exigen modos distintos, y de que la habilidad de elegir el modo es una competencia ejecutiva que puede entrenarse.

Cómo aplicar

1

Presentación de los personajes (10 min)

Presente al Robot: «Pensá en un robot: sigue paso a paso, uno por vez, no salta etapas, verifica antes de ir al siguiente. Es muy bueno para seguir recetas, hacer pruebas, armar muebles». Presente al Artista: «Pensá en un artista: conecta ideas al azar, piensa en diez cosas a la vez, inventa soluciones que nadie pensó. Es muy bueno para crear, resolver problemas de forma original, tener ideas nuevas». Pregunte: «¿En cuál te parecés más?».

2

Mapeo de situaciones por modo (10 min)

Liste 10 situaciones de la vida del niño. Para cada una, identifiquen juntos: ¿esta situación pide más al Robot o al Artista? (Prueba de matemática = Robot; redacción creativa = Artista; jugar al Minecraft = los dos; charlar con amigos = más Artista; seguir la rutina de la mañana = Robot). El objetivo es que el niño empiece a hacer esa lectura contextual de forma automática.

3

Práctica de cambio de modo (15 min)

Proponga una tarea que exige al Robot (una secuencia de instrucciones para armar algo simple). Observe cuándo el Artista «invade»: el niño improvisa, salta etapas, inventa una solución distinta. Nómbralo: «Llegó el Artista, ¿qué pasó?». Después proponga una tarea creativa y observe si el Robot interfiere (rigidez, autocritica, miedo a equivocarse). Diga: «Hoy el Robot está molestando al Artista. ¿Cómo dejamos que el Artista trabaje?».

El ritual de cambio de modo (5 min)

Cree un ritual de activación de modo para usar fuera de la sesión: «Para activar al Robot: respirá hondo, mirá la primera etapa, hacé solo la primera. Para activar al Artista: cerrá los ojos, dejá que la cabeza corra, anotá todo lo que aparezca sin juzgar». Acuerden cuándo va a usar cada ritual.

Lectura clínica

Observe cuál modo es más difícil para el niño: eso revela el patrón predominante de interferencia del TDAH. Un niño que activa al Artista todo el tiempo y tiene dificultad para entrar en el modo Robot tiene la impulsividad y el pensamiento asociativo como manifestación dominante: el trabajo se enfoca en activar deliberadamente el modo Robot. Un niño que quedó tan adaptado al fracaso que suprimió al Artista (rígido, sin creatividad, con miedo a equivocarse) desarrolló una estrategia de supervivencia que sacrificó el mayor punto fuerte del TDAH. Rescatar al Artista en ese niño es parte crucial del trabajo de autoestima.

Preguntas orientadoras

- ¿En qué modo te parecés más? ¿En cuál te sentís más cómodo?
- ¿Hay situaciones donde el Artista molesta al Robot para hacer el trabajo? ¿Cuáles?
- ¿Podés recordar una vez que tu modo Artista resolvió un problema que nadie más resolvió?
- ¿Qué perdiste por ser muy Artista en una situación que necesitaba al Robot?
- Si pudieras elegir un solo modo para toda la vida, ¿cuál elegirías? ¿Por qué?

Adaptaciones

Para niños con perfil de TDAH combinado (atención e hiperactividad): suelen alternar entre los dos modos de forma caótica, sin control intencional. El trabajo es de reconocimiento —«¿en qué modo estoy ahora?»— antes de trabajar el cambio deliberado.

Para niños con comorbilidad de TEA leve: el modo Artista puede ser muy difícil de acceder por rigidez cognitiva; en ese caso, la intervención se enfoca en expandir la flexibilidad cognitiva, no en alternar entre modos ya establecidos.

TIPO	Técnica cognitiva de proyección de consecuencias para TDAH con impulsividad
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	TDAH con impulsividad que genera consecuencias repetidas y previsibles — niño que «siempre cae en lo mismo» sin lograr anticipar que va a pasar de nuevo
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja con una cadena de seis eslabones dibujada, marcadores

Objetivo

Desarrollar la capacidad de proyección de consecuencias —anticipar qué va a pasar como resultado de una acción antes de actuar—, uno de los déficits ejecutivos más relevantes clínicamente en el TDAH. Los niños con TDAH suelen actuar en el «ahora» sin procesar el «después»: la memoria prospectiva (capacidad de visualizar consecuencias futuras) está comprometida por la dificultad de inhibición y por la orientación al presente inmediato. El resultado es que la misma situación genera la misma consecuencia una y otra vez, y el niño genuinamente no comprende por qué sigue pasando. La Cadena de la Consecuencia usa una estructura visual que vuelve visible la secuencia de eventos que normalmente se procesa de forma implícita y automática —y que en el TDAH, simplemente no se procesa—. Fundamentada en la técnica de análisis funcional conductual y en el modelo de procesamiento prospectivo de Barkley.

Cómo aplicar

1

Elección de una situación recurrente (5 min)

Identifique con el niño una situación impulsiva que se repite y genera las mismas consecuencias. Ejemplos: pegarle a un compañero cuando lo provoca, decir una mala palabra en clase, agarrar el celular de la mamá sin pedir. Deje que el niño elija —la autonomía en la elección aumenta el compromiso con el análisis—.

2

Construcción retroactiva de la cadena (15 min)

Parta del final (la consecuencia que el niño más detesta) y construya la cadena hacia atrás: «¿Qué pasó antes de esto? ¿Y antes de eso? ¿Y qué estaba pasando al principio?». Cada eslabón es un momento de la secuencia. Ese mapeo retroactivo revela la cadena que el niño no percibe en tiempo real: disparador → pensamiento automático → impulso → acción → consecuencia inmediata → consecuencia tardía.

3

Identificación del eslabón de intervención (10 min)

Pregunte: «¿En qué eslabón de la cadena podrías haber hecho algo distinto?». Identifique el punto de mayor posibilidad de intervención —por lo general el momento entre el impulso y la acción, no después de la acción—. Diga: «No podés evitar el disparador ni el impulso. Pero podés entrenar qué hacer con el impulso antes de actuar». Acuerden una acción específica para ese eslabón.

Proyección prospectiva (10 min)

Ahora dé vuelta la cadena hacia adelante: parta de la situación disparadora y proyecte los dos caminos posibles. Camino A: actúa por impulso → eslabones de la cadena → consecuencia que detesta. Camino B: usa el eslabón de intervención → eslabones alternativos → consecuencia distinta. Diga: «Acabás de hacer que tu cerebro simule el futuro. Eso es lo que no hace de forma automática, pero acabás de probar que lo lograrás cuando lo intentás».

Lectura clínica

Observe el nivel de insight del niño sobre su propia cadena. Un niño que reconoce el patrón con facilidad («siempre pasa así») tiene el automonitoreo relativamente preservado: el problema no es falta de insight, sino falta de acceso al insight en tiempo real. Un niño que no reconoce el patrón ni siquiera al ver la cadena armada tiene un compromiso más profundo del automonitoreo: el trabajo de conciencia precede al de intervención. Cuando el niño identifica múltiples eslabones donde podría intervenir, celébrelo: indica flexibilidad cognitiva emergente.

Preguntas orientadoras

- Cuando ves la cadena armada así, ¿el patrón era esperable o te sorprendió?
- ¿En qué eslabón te parece más difícil intervenir? ¿Por qué?
- ¿Alguna vez lograste romper la cadena antes de la consecuencia mala?
- ¿Qué sentís cuando ya estás en el eslabón de la acción y sabés que te vas a arrepentir pero lo hacés igual?
- Si pudieras grabar esta cadena en la cabeza para acordarte cuando llegue el impulso, ¿qué parte grabarías?

Adaptaciones

Para niños con comportamiento agresivo recurrente: el análisis de la cadena está muy indicado, pero asegúrese de que el trabajo de regulación emocional esté ocurriendo en paralelo —la proyección de consecuencias es muy difícil cuando hay una activación emocional intensa—. El eslabón de intervención debe ser una acción que el niño pueda ejecutar aun en un estado de excitación moderada.

Para niños más pequeños (5 a 6 años): simplifique a tres eslabones: qué pasó, qué hice, qué vino después. La cadena completa de seis eslabones es para niños con mayor capacidad de abstracción.

TIPO	Instrumento de evaluación e intervención en el campo de relaciones del niño
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con dificultades de relación — niño sin amigos, con amistades inestables, que pierde amigos por conductas impulsivas, o que se relaciona predominantemente con niños mucho más chicos o más grandes
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja grande con círculos concéntricos (mapa sociométrico), marcadores de colores

Objetivo

Evaluar y trabajar el campo de relaciones sociales del niño desde una perspectiva ecológica —mapeando quiénes son las personas en su vida, la calidad y cercanía de esas relaciones, y los patrones relacionales que produce el TDAH—. Los niños con TDAH presentan tasas mucho mayores de dificultad de amistad que sus pares: son rechazados por conductas impulsivas, percibidos como invasivos o irritantes, con dificultad para mantener la reciprocidad que la amistad exige en el tiempo. Algunos desarrollan un patrón de amistades con niños más chicos (donde el déficit de madurez se percibe menos) o más grandes (donde se los tolera más). El mapa de las amistades no es solo evaluativo, es terapéutico: el proceso de mirar las relaciones ayuda al niño a identificar qué ha funcionado y qué no, creando base para una intervención específica.

Cómo aplicar

1

Construcción del mapa (15 min)

Entregue la hoja con cuatro círculos concéntricos. Explique: «En el centro estás vos. En el primer círculo van las personas más cercanas: tu mejor amigo, alguien con quien te sentís completamente a gusto. En el segundo, amigos copados pero no tan cercanos. En el tercero, conocidos y compañeros. En el cuarto, personas con las que interactuás pero no considerás amigos». El niño completa con nombres. No interfiera en dónde va cada persona: la disposición revela su percepción sobre las relaciones.

2

Análisis del patrón (10 min)

Observe con el niño: «Mirando el mapa, ¿qué notás?». Preguntas de análisis: ¿cuántas personas hay en el círculo más cercano?, ¿hay más niños de tu edad, más chicos o más grandes?, ¿las amistades son del contexto escolar o de otros contextos?, ¿hay alguien que te gustaría que estuviera más cerca en el mapa?, ¿alguien que fue más cercano y se alejó?

3

La historia de una amistad importante (10 min)

Pida que el niño elija una amistad del mapa —una que va bien, una que está difícil, o una que se perdió—. Explore: cómo empezó, qué la mantiene o la mantuvo, qué la está dificultando, qué hace el niño que ayuda o perjudica esa amistad. Ese relato es rico en datos sobre el patrón relacional específico del TDAH en este niño.

Una acción para el campo social (5 min)

Identifique una acción concreta que el niño quiera intentar en la semana: invitar a alguien a jugar, pedir disculpas por algo que pasó, intentar una conversación nueva con alguien del círculo externo. Muy específica: quién, cuándo, dónde, qué va a decir.

Lectura clínica

El patrón del mapa revela mucho sobre el impacto social del TDAH en este niño en particular. Un círculo interno vacío o con solo adultos (padres, maestros) indica un aislamiento social significativo —el niño no tiene pares genuinamente cercanos, un factor de riesgo para el desarrollo emocional y para la depresión—. Un mapa con muchas personas pero todas en círculos externos indica relaciones superficiales y dificultad de profundización —típico del TDAH con impulsividad que aleja cuando la relación se vuelve más exigente—. Un mapa con niños predominantemente más chicos plantea la cuestión de la madurez social: investigue si el niño se siente más competente con niños más chicos.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay alguien en el mapa que te gustaría que estuviera más cerca? ¿Qué lo impide?
- ¿Hay una amistad que perdiste por algo que pasó? ¿Qué fue?
- ¿Qué te parece que es lo que más les gusta de vos a las personas del primer círculo?
- ¿Alguna vez una amistad terminó por algo que hiciste por impulso?
- ¿Qué tipo de amigo sos? Si tu mejor amigo te describiera, ¿qué diría?

Adaptaciones

Para niños con aislamiento social severo: el trabajo de habilidades sociales individual no alcanza. Considere la derivación a un grupo terapéutico con pares o a actividades estructuradas de interés (deporte, club) donde la interacción tiene una actividad como mediadora, reduciendo la demanda de habilidad social espontánea.

Para niños con amistades inestables por impulsividad: trabaje «La Cadena de la Consecuencia» (recurso 36) específicamente para situaciones de amistad antes de trabajar el mapa.

TIPO	Psicoeducación sobre la fatiga ejecutiva y entrenamiento del automonitoreo de recursos cognitivos
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con empeoramiento significativo de los síntomas a lo largo del día — niño que funciona razonablemente por la mañana pero colapsa a la tarde, con muchas más explosiones y errores en los períodos de mayor demanda ejecutiva acumulada
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Hoja con un medidor de batería de smartphone (0 a 100%), marcadores

Objetivo

Desarrollar en el niño la conciencia de que las funciones ejecutivas son un recurso limitado que se agota a lo largo del día —y de que cuando ese recurso está bajo, los síntomas del TDAH se vuelven mucho más intensos— y entrenar estrategias de recarga que restauran temporalmente la capacidad ejecutiva. El fenómeno de la fatiga ejecutiva en el TDAH es clínicamente relevante y a menudo incomprendido por la familia: el niño que funciona adecuadamente a la mañana y parece «empeorar a propósito» a la tarde no está siendo voluntariamente difícil —sus recursos ejecutivos están genuinamente agotados por el esfuerzo de regularse durante todo el día escolar—. La metáfora de la batería es concreta y universalmente comprendida por los niños de la era digital, y ofrece un encuadre no estigmatizante para la variación diaria de los síntomas.

Cómo aplicar

1

La metáfora de la batería (5 min)

Explique: «¿Sabés cómo el celular tiene batería? A la mañana está en 100%. Si lo usás mucho, a la tarde puede estar en 20% y se pone lento, se cuelga, no funciona bien. Tu cerebro con TDAH tiene una batería parecida, pero se gasta más rápido que la de la mayoría, porque mantener el foco y controlar los impulsos exige mucha más energía de tu cerebro que del de la mayoría de las personas. Después de un día entero de escuela, la batería ejecutiva puede estar casi en cero».

2

Mapeo del consumo de batería (15 min)

Mapee con el niño un día típico y estimen cuánto gasta la batería en cada momento: escuela (mucho consumo —control de impulso, atención forzada, relación con pares—), recreo (recarga un poco), la tarde con la tarea (alto consumo, ya con batería baja), la cena familiar (bajo consumo si es relajada, alto si hay conflicto). Al final, el niño ve visualmente por qué la tarde es más difícil: no es que empeoró, es que la batería está más baja.

Estrategias de recarga (15 min)

Identifiquen qué recarga la batería ejecutiva y qué parece recargar pero en realidad gasta más: recargadores reales (movimiento físico libre, tiempo sin demanda cognitiva, una actividad de hiperfoco relajante, el sueño); falsos recargadores (pantalla con juegos competitivos —genera activación simpática, no recarga—; el conflicto familiar —gasta más—). Construyan el «menú de recarga» personalizado del niño. Acuerden un intervalo de recarga de 20 a 30 minutos después de la escuela antes de cualquier tarea.

Lectura clínica

Observe el patrón de desempeño del niño a lo largo de las sesiones, no solo del día. Las sesiones de la tarde (después de la escuela) tienden a ser más difíciles que las de la mañana con niños con TDAH por la fatiga ejecutiva acumulada. Si es posible, considere el horario de las sesiones como una variable clínica. Observe también si la variación diaria de síntomas que relata la familia es consistente con el modelo de fatiga (empeoramiento progresivo a lo largo del día) o si hay otros patrones (empeoramiento en contextos específicos independientemente del horario): eso orienta si la intervención debe ser en la fatiga o en la regulación contextual.

Preguntas orientadoras

- ¿En qué horario del día te sentís con más energía para pensar y controlarte?
- ¿Qué te pasa después de pasar el día entero en la escuela?
- ¿Cuál es tu actividad favorita de recarga, la que te deja sintiéndote mejor?
- ¿Lográs darte cuenta cuando tu batería se está poniendo baja? ¿Cómo lo sabés?
- Si pudieras tener 30 minutos de recarga garantizados todos los días, ¿en qué horario y haciendo qué?

Adaptaciones

Para familias que programan la tarea inmediatamente después de la escuela: use el modelo de la batería para negociar el intervalo de recarga. Los datos de investigación apoyan que los niños con TDAH producen tareas de mucha mejor calidad después de un intervalo de movimiento libre que inmediatamente después de la escuela.

Para niños con TDAH en uso de medicación estimulante: la ventana de efecto de la medicación suele coincidir con el período escolar, y el «efecto rebote» al final de la tarde puede imitar la fatiga ejecutiva pero tiene otro mecanismo. Ese dato es relevante para comunicar al médico.

TIPO	Técnica de entrenamiento de atención auditiva con privación del input visual para ampliar el procesamiento auditivo
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	TDAH con déficit de atención auditiva en ambientes con múltiples estímulos visuales — niño que depende mucho del input visual y tiene dificultad para procesar instrucciones solo por el canal auditivo
DURACIÓN	30 a 35 minutos
MATERIALES	Venda o pañuelo para cubrir los ojos (con acuerdo del niño), objetos diversos para identificación táctil y auditiva, historias cortas

Objetivo

Entrenar el canal auditivo de forma intensiva al aislar temporalmente el input visual, forzando al sistema de atención a procesar exclusivamente por el canal auditivo y el procesamiento táctil. En los niños con TDAH suele haber una dependencia excesiva del estímulo visual (más inmediato y capturante) en detrimento del procesamiento auditivo, lo que crea dificultad cuando el contexto exige atención auditiva sostenida (instrucciones verbales de la maestra, conversación telefónica, audiolibro). La privación temporal y voluntaria del canal visual amplifica el procesamiento auditivo y vuelve consciente lo que normalmente es automático. El recurso es lúdico y se basa en principios de entrenamiento sensorial-cognitivo usados en rehabilitación neurológica y en entrenamiento de atención selectiva.

Cómo aplicar

1

Presentación y acuerdo (5 min)

Presente la actividad como un desafío especial de detective: «Hoy vas a usar un superpoder diferente: escuchar y sentir sin ver. Tus ojos van a descansar y tu oído va a ser el héroe». Obtenga acuerdo explícito y establezca la regla de que el niño puede sacarse la venda en cualquier momento si quiere. La seguridad y la autonomía son esenciales: la venda nunca se impone.

2

Actividades de atención auditiva sin visión (15 min)

Con la venda en los ojos, conduzca una serie progresiva de desafíos auditivos: (1) identificar los sonidos del ambiente —¿qué escuchas ahora? Enumera todo—; (2) identificar objetos solo por el sonido (agitar una cajita con clips, golpear distintas superficies); (3) escuchar una historia de 5 frases y responder preguntas enseguida; (4) seguir una secuencia de 3 instrucciones verbales simples. Aumente gradualmente la complejidad a medida que el niño tenga éxito.

3

Comparación con y sin visión (10 min)

Sáquele la venda. Repita una versión equivalente de las mismas actividades con los ojos abiertos. Conversen: «¿Fue más fácil o más difícil escuchar con los ojos cerrados? ¿Qué notaste cuando no tenías nada para mirar?». Para muchos niños con TDAH, la actividad auditiva es más fácil sin la visión porque elimina los distractores visuales: ese dato es clínicamente rico y puede informar estrategias de estudio (cerrar los ojos para escuchar instrucciones complejas).

Lectura clínica

Observe la reacción del niño a la privación visual. Un niño con ansiedad intensa al cubrirse los ojos puede tener un componente de ansiedad generalizada o de trauma: no fuerce y use alternativas (ojos cerrados voluntariamente, mirar hacia abajo) en lugar de la venda. Un niño que rinde significativamente mejor sin el input visual que con él tiene probablemente un perfil de sobrecarga de estimulación visual: el aula con muchos estímulos visuales está perjudicando activamente su atención auditiva. Ese dato puede orientar la recomendación de asiento en el aula (lejos de ventanas, de paredes con menos elementos visuales).

Preguntas orientadoras

- Cuando cerraste los ojos, ¿qué pasó con lo que escuchabas?
- ¿Fue más fácil o más difícil concentrarte en lo que yo decía sin ver?
- ¿Qué sonidos escuchaste con los ojos cerrados que no habías notado antes?
- ¿Usarías esta técnica en alguna situación real, tipo cerrar los ojos para escuchar mejor?
- ¿Qué fue más difícil: recordar lo que oíste, entender lo que oíste, o prestar atención mientras oías?

Adaptaciones

Para niños con sensibilidad sensorial intensa (perfil de procesamiento sensorial atípico): la venda puede ser muy incómoda por razones táctiles; use alternativas como cerrar los ojos voluntariamente o antifaz suave.

Para niños con sospecha de trastorno del procesamiento auditivo: el recurso puede revelar dificultades que persisten aun con la máxima atención; esos datos deben derivarse a evaluación fonoaudiológica especializada, no trabajarse aislados en sesión de psicología.

TIPO	Ritual de consolidación y herramienta de prevención de recaída para el cierre del tratamiento
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Fase final del acompañamiento — complementario o alternativo al ritual de cierre principal, con foco específico en la preparación para momentos de crisis futura
DURACIÓN	50 a 60 minutos
MATERIALES	Sobre cerrado, hoja de carta, hoja del kit de emergencia, cajita o bolsa decorada para guardar la cápsula

Objetivo

Crear un artefacto terapéutico concreto —la cápsula del tiempo— que el niño puede consultar en momentos futuros de recaída, crisis o duda sobre sí mismo, funcionando como un ancla de identidad construida a lo largo del tratamiento. El TDAH es un trastorno crónico cuyo curso puede intensificarse en períodos de transición (entrada en la adolescencia, cambio de escuela, aumento de las demandas académicas). Los niños que cerraron el tratamiento con avances reales pueden experimentar en esos momentos una regresión que parece borrar todo lo construido. La cápsula del tiempo funciona como un «mensaje del yo más fuerte al yo que está pasando por un momento difícil», basada en el principio narrativo de que la identidad necesita anclarse en evidencia concreta para resistir las narrativas de crisis. Complementa el recurso 20 con foco específico en el manejo de la recaída.

Cómo aplicar

1

La carta para el yo del futuro en crisis (15 min)

Proponga: «Imaginate que dentro de un año estás pasando por un período difícil con el TDAH: las cosas están más difíciles de nuevo, te sentís incapaz. El vos de hoy, que ya aprendió tanto, le va a escribir una carta a ese vos del futuro». La carta debe incluir: lo que el niño sabe sobre su propio TDAH que le llevó tiempo aprender, qué herramientas le funcionan a él específicamente, qué quiere que el yo del futuro recuerde en los momentos difíciles, y un mensaje de aliento genuino (no genérico, específico para él).

2

El kit de emergencia ejecutiva (15 min)

Construya el kit de emergencia: una lista de 5 a 7 acciones específicas que el niño sabe que le funcionan cuando el TDAH está intenso. No intervenciones genéricas, sino acciones probadas y validadas a lo largo del tratamiento. Formato: «Cuando [síntoma específico], hago [acción específica]». Ejemplo: «Cuando no logro empezar la tarea, uso la misión de 2 minutos y pongo el timer». Ese kit es el resultado de todo el aprendizaje del tratamiento condensado en formato práctico de crisis.

3

Qué va en la cápsula (10 min)

Ponga en la cápsula: la carta al yo del futuro, el kit de emergencia, el termómetro del TDAH de la última semana (como evidencia del nivel actual), un ítem simbólico del tratamiento elegido por el niño (una de las tarjetas, un dibujo, una ficha). Cierre el sobre. Instruya: «Esta cápsula solo puede abrirse en un momento de verdadera dificultad con el TDAH, no por curiosidad, sino cuando necesites ayuda».

Acordar el ritual de apertura (10 min)

Defina con el niño quién guarda la cápsula (él, la familia), cuándo puede abrirse (criterios específicos) y qué hacer después de leerla (puede buscar una sesión de retorno, usar el kit de emergencia una semana, hablar con alguien de confianza). Construya un plan de retorno claro: «Si después de usar el kit dos semanas las cosas no mejoran, es hora de venir a verme de nuevo. No es un fracaso: es mantenimiento».

Lectura clínica

Observe el contenido de la carta que el niño escribe para el yo del futuro: es uno de los instrumentos proyectivos más ricos del cierre. Una carta centrada en herramientas y estrategias indica que el niño integró los aprendizajes de forma funcional. Una centrada en el aliento emocional indica que el trabajo de autoestima fue el más transformador. Una carta muy corta y superficial puede indicar que el niño todavía no consolidó lo suficiente los logros para que el cierre sea adecuado: considere algunas sesiones más antes de cerrar. El contenido del kit de emergencia es el mejor indicador de qué intervenciones del tratamiento se internalizaron de verdad: compárelo con lo que usted creía que había funcionado y observe las discrepancias.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué es lo que más querés que tu yo del futuro recuerde sobre lo que aprendió acá?
- ¿Cuál es la herramienta que tenés más seguridad de que vas a usar aun lejos de acá?
- ¿En qué momento abrirías la cápsula? ¿Sabés reconocer ese momento?
- ¿Qué escribirías en la carta que sería distinto de lo que habrías escrito el primer día que viniste?
- Si pudieras poner una sola cosa en la cápsula para el yo del futuro, ¿qué sería?

Adaptaciones

Para niños que cierran con avances parciales y no totales: adapte la cápsula para ser más honesta sobre lo que todavía es difícil —una cápsula que promete que «todo va a estar resuelto» es una mentira que va a decepcionar en el momento de crisis—. La cápsula más útil es la que reconoce lo que sigue siendo un desafío y ofrece estrategias específicas para esos desafíos.

Para adolescentes que reciben la cápsula más tarde: el kit de emergencia puede necesitar revisión porque las demandas de la adolescencia son distintas de las de la infancia. Oriente a la familia a revisar el contenido de la cápsula junto con el niño al entrar en la adolescencia, aunque el niño esté bien.